

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Eva de las Nieves Rodríguez, Gema M^a Gómez García, M^a Fátima Fernández Salgado

INTRODUCCIÓN

Las infecciones de transmisión sexual siguen un continuo crecimiento tanto en España como en Europa desde el siglo XXI, parece que debido a la falta de información/concienciación entre adolescentes y adultos jóvenes. La ausencia de un diagnóstico y tratamiento precoz, conlleva graves complicaciones y secuelas.

La evaluación inicial debe incluir:

- Anamnesis detallada: comportamiento sexual de riesgo, parejas y género en los 90 días previos, viajes (turismo sexual), otros síntomas acompañantes, historia previa de ETS, uso de drogas.
- Examen físico: local y general
- Pruebas diagnósticas: necesarias por la variabilidad de síntomas en las ETS desde floridas a asintomáticas, o por la presentación, a veces atípica, de las mismas.
- Tratamiento empírico: puesto que la mayoría de las pruebas diagnósticas tardarán varios días en ofrecer sus resultados, y otras, más rápidas y de elevado coste, no están disponibles en los servicios de Urgencias. Abordar la/s pareja/s sexual/es si fuese posible y canalizar al paciente en el despistaje de otras ETS, dado que en múltiples ocasiones concurren juntas.
- Asesoramiento sobre los test a realizar y el uso aconsejado de condón, y asegurar la siguiente visita en la primera semana tras el inicio del tratamiento para evaluar la respuesta clínica y revisar los resultados de las pruebas diagnósticas practicadas.

Recordemos que son Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) la Sífilis, la Infección Gonocócica, el Linfogranuloma venéreo y el VIH/SIDA.

1. URETRITIS-CERVICITIS-PROCTITIS

Introducción:

La Chlamydia trachomatis es la causa bacteriana más frecuente de enfermedad de transmisión sexual (serotipos D-K), seguida de Neisseria gonorrhoeae. Existe infección simultánea en el 30% de los casos. Otros agentes causales son U. Urealyticum y M. genitalium. Pueden provocar infecciones urogenitales o anorectales (proctitis tras relación sexual anal receptiva, considerar además como agentes causales VHS y sífilis que se exponen más adelante en este capítulo).

Diagnóstico:

Clínica

Síntomas de uretritis: disuria y secreción uretral unos 3-5 días tras contacto sexual en gonocócica y 1-2 semanas en no gonocócica.

Síntomas cervicitis: exudado endocervical purulento o sangrado endocervical al roce, aunque suele ser asintomática y constituye el reservorio.

Síntomas proctitis: tenesmo rectal, sangrado o mucosidad rectal, dolor anorectal que empeora al defecar, estreñimiento, plenitud rectal (pueden ser asintomáticos)

Diagnóstico sindrómico

*Secreción uretral mucoide o purulenta más uno de los siguientes:

- Gram secreción uretral con >5 leucos/campo (si se observan diplococos gramnegativos en el interior de los neutrófilos se trata de uretritis gonocócica)
- Primer chorro orina con estearasa leucocitaria + ó >5 leucos/campo

*Exudado endocervical purulento más >10 leucos/campo en fluido vaginal.

Diagnóstico etiológico

La realización de PCR es la más sensible y específica para N. gonorrhoeae y C. trachomatis en el primer chorro de la orina en el varón (no es necesario el frotis uretral) y en frotis endocervical en la mujer. Se recogerán hisopos faríngeos o rectales si existe historia de sexo oral/anal sin protección. Para el gonococo también se utiliza el cultivo de Thayer-Martin que permite realizar antibiograma.

Tratamiento:

Debe iniciarse en el momento de la primera visita, así fuese sólo un diagnóstico sindrómico. Se deben tratar ambos agentes debido al alto índice de coinfección. Los objetivos son prevenir complicaciones, disminuir el riesgo de transmisión y resolución de síntomas.

*De elección: Ceftriaxona 500 mg im dosis única + Doxiciclina 100 mg c/12horas x 7 días (preferible Azitromicina 1 gr en dosis única en embarazadas)

*No disponible im: Cefixima 800 mg vo + Azitromicina 1 gr vo (ambas dosis única)

*Alérgicos a penicilinas: Gentamicina 240 mg im + Azitromicina 2 gr vo (ambas dosis única).

Complicaciones:

- **Orquiepididimitis:** epidídimo engrosado y doloroso
- **Enfermedad inflamatoria pélvica:** dolor pélvico o abdominal, sangrado vaginal anormal, dispareunia incluso fiebre.
- **Perihepatitis (síndrome Fitz-Hugh-Curtis) en mujeres:** dolor en HCD, náuseas, vómitos y fiebre debidos a la inflamación de la cápsula de Glisson asociado a enfermedad inflamatoria pélvica. Función hepática normal o levemente elevada en los análisis.
- **Infección gonocócica diseminada:** bacteriemia que sucede en el 0'5-3% de los infectados. Existen dos cuadros clínicos: artritis purulenta o la triada de tenosinovitis, dermatitis y poliartralgias. Resultan raras la endocarditis, meningitis u osteomielitis.
- **Artritis reactiva:** sólo o asociada a la triada artritis + conjuntivitis/uveítis + uretritis/cervicitis (frecuentemente asociado a *C. trachomatis*)
- **Conjuntivitis:** principalmente afecta a recién nacidos de madres no tratadas, aunque se han descrito casos en adultos y adolescentes por autoinoculación; también existen casos de transmisión por fómites o moscas.
- Ruptura prematura de membranas en mujer gestante

Consejo y seguimiento:

Se aconsejará a los pacientes abstinencia sexual hasta una semana después de haberse iniciado el tratamiento. Todas las parejas sexuales de los 60 días previos al diagnóstico han de ser evaluadas y/o tratadas (especialmente mujeres asintomáticas).

A toda mujer en edad fértil que acude con infección urogenital, se le practicará un test de embarazo.

Se debe comprobar la curación mediante cultivo, a los tres meses del tratamiento, a todo individuo diagnosticado de infección gonocócica urogenital o anorrectal (en especial en mujeres embarazadas) para evaluar reinfección.

2. ÚLCERAS GENITALES

Las enfermedades de transmisión sexual son la causa más frecuente de úlceras genitales, siendo las más prevalentes en España el herpes (HSV 1 y 2) y la sífilis (*Treponem pallidum*). Desde 2005, se vienen detectando brotes de linfogranuloma venéreo (LGV) en hombres que tenían relaciones sexuales con hombres (HSH). Aunque la anamnesis y exploración física darán importantes pistas sobre el diagnóstico, permitiendo en muchos casos el inicio de un tratamiento empírico, se deben recoger las muestras adecuadas para su análisis y confirmación etiológica. En cualquier caso, siempre se realizará la prueba de HSV (si no se dispone de confirmación microbiológica en brote previo) y sífilis, y se derivará para despistaje de VIH, gonococo y chlamydia. A pesar de ello, el 25% de las úlceras genitales, quedarán sin diagnóstico confirmado por laboratorio.

El tratamiento empírico se iniciará ante la exposición a una ETS conocida, úlceras genitales sugestivas de infección por virus herpes simple o sífilis, o en una situación de brote detectado de linfogranuloma venéreo. También se administraría medicación ante lesión sugestiva de cancroide si sospechamos que el paciente no realizará seguimiento posterior. Hay que tener en cuenta, que la presencia de úlceras genitales es un factor de riesgo para la transmisión del VIH.

También recibirán tratamiento, aún asintomáticos, los contactos de pacientes con sífilis primaria, cancroide o linfogranuloma venéreo.

2.1 SÍFILIS

Introducción

ETS causada por la espiroqueta *T. pallidum*. Presenta periodo de incubación de 2-6 semanas.

Vía de inoculación es a través de lesiones en mucosa o piel durante las relaciones sexuales. Las vías congénitas, fómites y transfusiones son excepcionales.

Es frecuente su coinfección con VIH.

Presenta distintas manifestaciones clínicas en función de estadio. Dividiéndose en

Sífilis Temprana : 1º año desde la infección, que su vez se divide en Sífilis primaria y secundaria.

Sífilis Tardía o Terciaria.

Clínica:

Sífilis Primaria: aparece lesión cutánea papulosa de 1-2 cm que se ulcera, presentando bordes sobre-elevados indurados en la zona de inoculación, generalmente indolora --) **Chancro duro**. El periodo de incubación varía entre 3 a 90 días, siendo la media 21 días. Asociando adenopatías induradas en zona proximal, habitualmente bilaterales e indoloras. En pacientes VIH suelen ser múltiples chancros.

Desaparece de forma espontánea, incluso sin tratamiento en 3-6 semanas, por lo que muchos pacientes no consultan.

Sífilis Secundaria: en un 25% de pacientes no tratados durante la sífilis primaria, se produce una diseminación sistémica de la espiroqueta, habitualmente a las 2-6 semanas tras la desaparición del chancro se inicia clínica de sífilis secundaria.

- **Síntomas Constitucionales:** Fiebre, cefalea, anorexia, pérdida de peso, faringodinia...
- **Adenopatías:** Habitualmente en región cervical, axilar inguinal y femoral, de consistencia gomosa simétricas. Cuando aparecen en región epitroclear son prácticamente diagnósticas de Sífilis
- **Dermatológicas:**
 - **Rash** sobretodo maculopapular de color rojizo o marronáceo, simétricas en tronco, extremidades y en palmas y plantas (clavos sifilíticos, muy dolorosos) de 0.5 a 2 cm de diámetro. Escamosas, en alguna ocasión nodular
 - **Pústulas.**
 - **Lesiones mucosas:** Parches Mucosos: erosiones en mucosa oral o lengua. Pápulas partidas en comisura bucal. Condiloma lata: lesiones alargadas, de color gris-blanquecino en zonas húmedas (boca, periné... zonas próximas a lesión 1º), muy contagiosas por tener todas numerosas espiroquetas
 - **Alopecia:** lesiones caída de pelo en cuero cabelludo, barba y cejas, de aspecto "apolillado", se resuelven con tratamiento de sífilis.
- **Alopecia:** lesiones caída de pelo en cuero cabelludo, barba y cejas, de aspecto "apolillado", se resuelven con tratamiento de sífilis.
- **Afectación gastrointestinal:**
 - Hepatitis sifilítica: Aumento de pA, transaminasas normales, cura con tto sífilis.
 - Infiltrado o ulceración extensa que puede confundirse con linfoma
- **Lesiones musculoesqueléticas:** sinovitis, periostitis...
- **Afectación renal:** síndrome nefrótico, HTA, Fallo renal, GNmembranosa, mejora con tto
- **Afectación neurológica y ocular:** aparece en sífilis temprana: Cefalea, meningitis, afectación meningovascular, ICTUS, uveítis anterior y posterior, coriorretinitis, necrosis retiniana, neuritis, muy importante el diagnóstico rápido de sífilis ante esta sintomatología.

Sífilis Tercaria o tardía: entre el 25-40% de los pacientes no tratados durante la sífilis temprana desarrollan las secuelas de este periodo. Puede aparecer desde pasado el 1º año de contagio hasta 30 años después. Las manifestaciones más frecuentes son:

- **Cardiovasculares:** aortitis: dilatación de la Aorta con Insuficiencia válvula aórtica, se ausculta 2º tono agudo. Aparece a los 15-30 años de la primoinfección.
- **Sífilis Gomosa:** granulomas y nódulos sobretodo en piel y huesos.
- **Neurosífilis:** afectación del SNC paresia y Tabes dorsal

En esta fase de la enfermedad es necesario demostrar la existencia de *Treponema pallidum* en las lesiones, principalmente de la clínica neurológica.

Sífilis Latente: asintomática.

Diagnóstico:

Ante una clínica compatible en paciente con relaciones sexuales de riesgo se deben realizar pruebas de laboratorio, que pueden ser directas o indirectas.

- **Directas:**
 - Microscopio de campo oscuro: visualización del T. pallidum en fluído analizado.
 - PCR T. pallidum
- **Indirectas:**
 - Serología (Diagnóstico más usado)
 - Pruebas No Treponémicas: RPR y VDRL
 - Pruebas Treponémicas : FTA-ABS, TPHA y MHA-TP
- **Diagnóstico de Neurosífilis:**
 - Análisis de LCR
 - Signos o síntomas de SNC o/y oculares.
 - Título de RPR o VDRL > 1:32
 - VIH con CD4 < 350
 - Sospecha ante fracaso terapéutico.

Tratamiento:

Hay que incluir a los contactos de 90 días previos a la clínica, aunque la serología sea negativa. Incluso a mujeres embarazadas y VIH

- **Sífilis Primaria y Secundaria o Latente Temprana:** Penicilina G 2.4mill i.m dosis única o Doxiciclina 100/12h 2 semanas
- **Sífilis Latente Tardía o indeterminada:** Penicilina G 2.4 mill im 1/semana 3 semanas, o Doxiciclina 100/12h 4 semanas
- **Neurosífilis:** Penicilina G 3-4 mill iv /4h 10-14 días o Ceftriaxona 2g iv/24h 10-14 días.

Tras la 1º dosis de Penicilina puede aparecer la reacción de JARISH-HERXHEIMER que consiste en fiebre, escalofríos, mialgias , cefalea, taquicardia , leucocitosis, vasodilatación con hipotensión que cede espontáneamente en 12-24h

Tras el tratamiento debe hacerse seguimiento serológico por su Médico de Enfermedades infecciosas.

2.2 VIRUS HERPES SIMPLE (VHS)

Introducción

Tanto VHS-1 como VHS-2 (más prevalente con el 80%) provocan infección genital y recurrencias. El contagio se produce por contacto directo de piel erosionada o dañada (oral-genital-anal) con las lesiones herpéticas, derivando en la primoinfección (tras periodo incubación de 2-12 días).

Síntomas (hasta 70% cursan asintomáticos): iniciales con quemazón, prurito, edema y eritema; aparición de vesículas umbilicadas, pequeñas y dolorosas que pueden confluir en úlceras de mayor tamaño y bordes festoneados. A veces se acompañan de adenopatías pequeñas y dolorosas. Puede cursar con disuria y exudado uretral/vaginal. Incluso presentar síntomas generales, sobre todo en la primoinfección, como fiebre, cefalea, malestar general y mialgias.

Duración: el episodio puede durar 3 semanas (10 días en recurrencias).

Complicaciones: se han descrito meningitis aséptica, radiculitis lumbosacra en “silla de montar” con mielitis, dificultades en la micción/defecación (episodios de retención aguda de orina).

Recurrencias: se desencadenan en situaciones de inmunosupresión, estados de estrés, durante la menstruación en mujeres o en el curso de otra infección. El agente causal más frecuente es el VHS-2. La presentación clínica suele ser de similar localización e intensidad a la primoinfección.

Diagnóstico:

Toma de muestra con torunda del exudado y fondo de la lesión (en medio viral) para PCR específica (o muestra del LCR). Los cultivos tienen sólo una sensibilidad del 50%.

Tratamiento:

Disminuye la duración, gravedad, desarrollo de complicaciones, riesgo de recurrencias y de transmisión a pareja sexual. Aciclovir iv se reserva para los casos de infección complicada.

Primer episodio	• Aciclovir 400mg VO c/8 horas x 7 -10 días ó • Fanciclovir 250mg VO c/8 horas x 7 -10 días ó • Valaciclovir 1000mg VO c/12 horas x 7 -10 días
Episodio recurrente	• Aciclovir 800mg VO c/8 horas x 2 días ó • Fanciclovir 1000mg VO c/12 horas un único día ó • Valaciclovir 500mg VO c/12 horas x 3 días
Terapia supresiva (si 6 ó más recurrencias al año)	• Aciclovir 400mg VO c/12 horas x 6 -12 días ó • Fanciclovir 250mg VO c/12 horas x 6 -12 días ó • Valaciclovir 1000mg VO c/24 horas x 6 -12 días

Tras la resolución de la primoinfección del virus herpes simple, puede existir secreción viral intermitente y asintomática incluso en ausencia de lesiones.

2.3 CHANCROIDEIntroducción

ETS infrecuente en Europa y en países desarrollados. Causada por *Haemophilus ducreyi*

Es típica de América del Sur, Caribe, India, África y sudeste asiático, de hecho su transmisión es por relación sexual con personas de estos países.

Clínica

Tiene un período de incubación de aproximadamente 4-10 días, apareciendo una pápula que rápidamente se convierte en pústula que se ulcera en zona central, blanda al tacto, de 1-2 cm. Puede ser única o múltiples.

Asocia frecuentemente adenopatía loco-regional dolorosa (más frecuente en hombres que en mujeres) que drena material purulento en los días siguientes a su aparición.

Diagnóstico

- Cultivo
- Gram del aspirado purulento de la adenopatía.
- PCR

Tratamiento

- Azitromicina 1g una dosis
- También puede usarse:
 - Ciprofloxacino 500 1/12h 3 días
 - Ceftriaxona 250 im unidosis
 - Eritromicina 500/8h vo 7 días

2.4 LINFOGRANULOMA VENÉREO (LGV)Introducción

Producido por los serotipos L1, L2, y L3 de *Chlamydia trachomatis* con capacidad de invadir y reproducirse en los ganglios linfáticos locales. Endémico de ciertas zonas de África, India, el sudeste asiático, América del Sur y el Caribe. En occidente cada vez se reportan más casos en hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que suelen cursar con proctitis más que con úlcera genital y linfadenopatías. La mayoría de los HSH que adquieren esta enfermedad, están además infectados por VIH, lo que supone mayor riesgo de transmisión.

La sintomatología se desarrolla en 3 fases:

- **Primera:** periodo de incubación 3-12 días; después, en el sitio de inoculación se produce una pequeña úlcera vs inflamación de la mucosa que se resuelve en pocos días de forma espontánea.
- **Segunda:** 2-6 semanas después, por extensión directa a los ganglios regionales inguinales/femorales. En los hombres se produce una gran inflamación profunda de ganglios inguinales, uni o bilateral, que coalescen formando grandes masas dolorosas llamadas bubones que pueden romperse. En la mujer esta reacción suele

suceder en los ganglios linfáticos perirrectales y pelvianos más profundos.

La infección anorrectal suele acompañarse de fiebre, malestar, tenesmo y sangrado/secreción rectal o dolor anal, desarrollando trayectos fistulosos o estenosis.

- **Tercera:** se generan cicatrices y trayectos fistulosos que pueden persistir o recidivar sobre todo en pacientes no tratados. La inflamación persistente de los ganglios en la infección no tratada puede provocar de forma tardía edema/elefantiasis genital, pelvis congelada, infertilidad y en casos extremos, destrucción generalizada de los genitales externos (más en mujeres).

Diagnóstico:

Realización de PCR en las diferentes muestras (según localización). La PCR que diferencia los serotipos de *C. trachomatis* no está siempre disponible y, además, tarda semanas en ofrecer el resultado. La serología puede ser útil en dos circunstancias: en tercer estadio si no existen secreciones de donde recoger la muestra o cuando el paciente ha sido tratado para Chlamydia de forma empírica y se precisa confirmar el diagnóstico de forma retrospectiva

Tratamiento:

En todos los pacientes incluso asintomáticos.

- ***De elección:**
 - Doxiciclina 100 mg vo c/12 horas x 3 semanas. (Si la presentación clínica es de proctocolitis, se añade Ceftriaxona 250 mg im dosis única)
- ***Alternativo:**
 - Azitromicina 1 gr vo una vez a la semana x 3 semanas.
- ***Mujeres embarazadas y lactantes:**
 - Eritromicina 500 mg vo c/6 horas x 3 semanas.

El paciente requiere seguimiento posterior durante 6 meses. Inicialmente para evaluar la respuesta al tratamiento que debe ser casi completa a los 21 días.

Se aconseja abstinencia sexual hasta que los síntomas se hayan resuelto y se haya completado el tratamiento, incluso el de su/s pareja/s sexual/es.

Todas las parejas sexuales de los 60 días previos al inicio de síntomas o diagnóstico deben ser tratadas:

- ***Asintomáticos:**
 - Azitromicina 1 gr vo dosis única ó
 - Doxiciclina 100 mg vo c/12 horas x 7 días (si los test confirman el diagnóstico se completará el régimen hasta las 3 semanas).
- ***Sintomáticos:** mismo tratamiento que el del paciente en espera del resultado de los test.

2.5 GRANULOMA INGUINAL O “DONOVANOSIS”

Introducción:

Se trata de una infección rara, causada por *Klebsiella granulomatis*, endémica de zonas como Papua Nueva Guinea, Australia, el sur de África, el Caribe y ciertas áreas de Brasil e India.

Clínica: tras un periodo de incubación de 1-12 semanas, aparece un nódulo cutáneo eritematoso, indoloro, de olor desagradable, que posteriormente se ulcera y se va extendiendo a otras áreas de la piel. Las lesiones, que pueden aparecer en región urogenital, anla/glútea incluso en la cara, curan y dejan cicatrices

Diagnóstico:

Examen microscópico que muestra los cuerpos de Donovan en el líquido obtenido de una lesión.

Tratamiento:

*De elección: Azitromicina 1 gr/semanal vo (ó 500 mg diarios) durante al menos 3 semanas o hasta que las lesiones se hayan curado por completo.

*Alternativo: Doxiciclina 100 mg vo cada 12 horas ó Eritromicina 500 mg vo cada 6 horas ó TMP/SMX 160/800 mg vo cada 12 horas.

Consejo y seguimiento:

Hay que observar la respuesta al tratamiento en los 7 días siguientes al inicio. A pesar de adecuada evolución, el paciente debe controlarse durante 6 meses.

Las parejas sexuales de los 60 días previos al inicio de los síntomas del caso, deben ser evaluadas y recibir tratamiento en caso de diagnóstico positivo, a pesar de encontrarse asintomáticas.

2.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ITS ULCEROSAS

	VHS	Chancroide	Sífilis	LGV	Granuloma inguinal
Dolorosa	+	+	-	-	-
Número	múltiples	múltiples	única	única	una o varias
Características	Vesículas agrupadas sobre base eritematosa	Profundas, irregulares, base amarillo-grisácea y borde violáceo excavado	Indurada y bien circunscrita	Poco profunda	Nódulos friables, se ulceran, bordes sobrelevados Lesiones "en beso"
Adenopatías inguinales	+ blandas	+ blandas y/o supuradas	+ gomosas (sífilis primaria tardía)	+ bandas y/o supuradas	-
Síntomas constitucionales	+ Fiebre, malestar, mialgias	-	+ cefalea, fiebre, malestar (sífilis secundaria)	+ fiebre, malestar, lumbalgia, dolor pélvico (2º estado)	-
Recurrencias	+	-	-	+ 3er estado	-
Meningitis aséptica/retención urinaria	+	-	-	-	-

3.- CONDILOMAS ACUMINADOS Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VHP)Introducción:

Producidos por VPH: Es la ETS más prevalente. Su importancia radica en su alta relación con aparición de lesiones precancerosas y cancerosas. Está presente en la menos 10% de la población. Afectando sobre todo al cérvix y al canal anal. Es altamente contagioso, la transmisión es por contacto con mucosa o piel infectada y presencia de microabrasiones, también se transmite por fómites y pudiendo un paciente autoinocularse.

Existe un elevado número de serotipos

- Los serotipos: 16, 18, 31, 33 y 35 son los de mayor riesgo de cáncer (genital y de cabeza y cuello).
- Los serotipos: 6, 11 y 42 producen condilomas acuminados

Hay factores de riesgo: como el tabaco, la actividad sexual, relaciones anales.

Diagnóstico:

Clínica: Condilomas acuminados o verrugas anogenitales: aparecen sobretodo en vulva, pene, ingle, periné, piel anal

Presentan múltiples formas: planos, filiformes, coliformes, pedunculados, como placas...

Su coloración puede variar: blanco, color de la misma piel, rojizo, marronáceo, hiperpigmentación...

Suaves y blandos a la palpación, de 1mm a varios cm de diámetro

Aunque habitualmente son asintomáticos pueden producir prurito, en caso de estar en cérvix o uretra producen coitorragia en ocasiones, sangrado uretra. Deformidad en región anogenital, produciendo molestias en la defecación cuando son de gran tamaño.

Rara vez malignizan..

Cribado:

- Biopsia
- Citología y Técnica de Papanicolau

Tratamiento:

- Cirugía
- Criocoagulación
- Conización laser C02
- Imiquimod crema 5%

Importancia prevención: métodos barrera y Vacunación

4. PEDICULOSIS PUBIS

Introducción

Pediculosis del pubis es habitualmente causada por *Phthirus pubis*, transmitida por relaciones sexuales que afecta principalmente a la zona púbica pero puede extenderse por otras partes del cuerpo, incluidas las pestañas. *P. pubis* es un parásito translúcido de 0,8 a 1,2 mm de largo. 3 de sus 6 patas terminan en una especie de pinza de cangrejo que le ayuda a agarrarse al vello. El ciclo de vida de la hembra es de unas 3-4 semanas de vida en las que pone 3 huevos/día que eclosionan en 6-8 días.

La transmisión es generalmente durante la relación sexual pero puede contagiarse por fómites, ropa, toallas.... Cuando aparecen en niños hay que descartar abusos.

Clínica:

- Prurito en zona púbica y perineal.
- Máculas azuladas (*maculae ceruleae*) de 0.5 a 1 cm en abdomen, glúteos y muslos, por inoculación de sustancia anticoagulante suelen estar presentes cuando el individuo lleva infestado largo tiempo.
- Costras por rascado
- Adenopatías inguinales.
- Irritación ocular y conjuntivitis (cuando hay infestación ciliar)

Diagnóstico:

- Visualización del parásito o liendre.

Tratamiento:

- **Permetrina** al 1% crema, champús y lociones dejar actuar durante la noche
- **Productos a base de siliconas.** El componente activo del pediculicida encapsula totalmente al parásito y bloquea sus espiráculos, de modo que el piojo es incapaz de expulsar el agua que obtiene a partir de la succión de sangre del hospedador y su intestino se colapsa. Las formulaciones incluyen una silicona no volátil activa (dimeticona) que se vehicula en una silicona volátil (ciclometicona), que a su vez se evapora tras su aplicación dejando sólo la silicona activa. El preparado se debe dejar actuar durante 8-12 h (algunos productos de reciente aparición son más inmediatos) y se aconseja repetir la aplicación tras 7 días
- **Piretroides al 0.33%.** Presentan poca acción ovicida y precisan de repetición del tratamiento una semana después de la primera aplicación.
- **Extracción manual de liendres**

BIBLIOGRAFÍA

- Tuddenham S, Ghanem KG. Approach to the patient with genital ulcers. [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; Dec 07, 2020 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Albrecht MA. Epidemiology, clinical manifestations and diagnosis of genital herpes simplex virus. [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; Dec 22, 2020 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Albrecht MA. Treatment of genital herpes simplex virus infection. [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; Jun 04, 2019 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Ríos German PP, Loeches Yagües B, Rico Nieto A. Úlceras genitales dolorosas y de larga evolución en paciente con leucemia linfática crónica. Revista Española de Geriátría y Gerontología [revista en Internet] Marzo-Abril 2017 [acceso 28 de marzo de 2021]; 52(2): 103-104. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-ulceras-genitales-dolorosas-larga-evolucion-S0211139X16300993>
- Díaz A, Ruiz-Algueró M, Hernando V. Linfogranuloma venéreo en España, 2005-2015: revisión de la bibliografía. Medicina Clínica [revista en Internet] Noviembre 2018 [acceso 28 de marzo de 2021]; 151(10): 412-417. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-linfogranuloma-venereo-espana-2005-2015-revision-S0025775318304445>
- Seña AC, Cohen MS. Treatment of uncomplicated *Neisseria gonorrhoeae* infections. [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; Jan 14, 2021 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>

- Ghanem KG. Clinical manifestations and diagnosis of *Neisseria gonorrhoeae* infection in adults. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Jun 17,2020 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Hsu K. Clinical manifestations and diagnosis of *Chlamydia trachomatis* infections. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Oct 21,2019 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Hsu K. Treatment of *Chlamydia trachomatis* infection. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Oct 21,2019 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Manual MSD. Versión para profesionales [sede Web]. Kenilworth, NJ, USA: Merck Sharp & Dohme Corp.; jul 2019 [acceso 28 de marzo de 2021]. Morris SR. Granuloma inguinal. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/enfermedades-infecciosas/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual/granuloma-inguinal>
- Manual MSD. Versión para profesionales [sede Web]. Kenilworth, NJ, USA: Merck Sharp & Dohme Corp.; jul 2019 [acceso 28 de marzo de 2021]. Morris SR. Linfogranuloma venéreo (LGV). Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/enfermedades-infecciosas/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual/linfogranuloma-ven%C3%A9reo-lgv>
- Hamill M. Lymphogranuloma venereum. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Sep 16,2019 [actualizado Feb 2021; acceso 28 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social. Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España [sede Web]. Madrid, junio 2019 [acceso 30 de marzo de 2021]. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Vigilancia ITS_1995_2017_def.pdf
- HicksCB. Chancroid. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Oct 17,2019 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Lewis , DA Epidemiology, clínica, features, diagnosis and treatment of *H. Ducreyi* , a disappearing pathogens?. Expert Rev antiinfection ther , 2014 , 12:687
- Rosen T. Condylomata acuminata (anogenital warts) in adults: Epidemiology, pathogenesis, clinical, diagnosis and treatment. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Feb 15,2019 [actualizado Feb 2021; acceso 18 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- De Villers EM, Fauquet C, Broker TR , et al. Classification of papillomaviruses virology 2004: 324:17
- Hicks CB, Clement M. Syphilis: Epidemiology, pathophysiology, and clinical manifestations in patients without HIV. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Nov 05,2020 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Jimenez Aranda P.-Capítulo 89: Enfermedades de transmisión sexual en Julian Jimenez (ed.y coord.) Manual de protocolos y actuación en urgencias. Toledo, Grupo SANED, pp 825-831
- RowleyJ, Vander Hoorn S, Korenromp E, et al. Chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis and syphilis: global prevalence and incidence estimates 2016. Bull World Health Organ 2019
- Goldstein AO, Goldstein BG. Pediculosis pubis and pediculosis ciliaris. . [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Oct 25,2018 [actualizado Feb 2021; acceso 18 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>

URTICARIA Y ANGIOEDEMA

Vanessa Gallego Fernández, María Fernández Mera, Antía Fernández Lorenzo, Francisco José Aramburu Vilariño, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La urticaria se define como la enfermedad caracterizada por el desarrollo de habones, angioedema o ambos.

Habón. El habón es una lesión máculo-papulosa eritematosa, con un halo pálido central de tamaño variable, confluyente, de aparición súbita en minutos-horas y de resolución rápida (evanescentes), generalmente en menos de 24 horas. Suele asociar prurito. Se distribuyen de forma heterogénea por cualquier parte del cuerpo, siendo más frecuentes en tronco, cara y extremidades. Característicamente no dejan lesión residual, excepto las producidas por el rascado.

Angioedema. El angioedema, que afecta a dermis profunda y/o submucosa, se presenta como edema sin fovea, de márgenes imprecisos y sin eritema. Puede asociar dolor. A diferencia de otros edemas que suelen aparecer en zonas declives del cuerpo, en el angioedema se suelen afectar labios, lengua, párpados, genitales y vía aérea superior. El angioedema en ausencia de urticaria es infrecuente y obliga a descartar diagnósticos alternativos como angioedema hereditario o adquirido.

Un episodio de urticaria con o sin angioedema puede ocurrir en el 10-20% de la población general y hasta un 30% de los casos pueden evolucionar a la cronicidad. La incidencia es levemente superior en mujeres: 1,5/1. Actualmente la European Academy of Allergology and Clinical Immunology recomienda clasificar la urticaria en base a duración y factores implicados:

Urticaria aguda: menor o igual a seis semanas. Más común en niños y adultos jóvenes. Generalmente dependiente de IgE; relacionada con alimentos, parásitos, fármacos (penicilina, amiodarona, captopril, etc).

Urticaria crónica: mayor de 6 semanas. Más frecuente en adultos. Raras veces dependiente de IgE pero a menudo se debe a autoanticuerpos anti-FcεR; se desconoce la causa en el 80% de los casos.

- **Espontánea:** Aparición espontánea de habones, angioedema o ambos durante > 6 semanas debido a causas conocidas (p. ej. la presencia de autoanticuerpos activadores de mastocitos) o desconocidas.
- **Inducible:**
 - . **A frigore:** por objetos, fluidos o aire fríos.
 - . **Por presión:** presión vertical. Latencia de 3-12 horas.
 - . **Por calor:** calor localizado.
 - . **Solar:** exposición solar. Inicio inmediato.
 - . **Dermografismo (facticia):** inicio inmediato.
 - . **Vibratoria:** exposición cutánea a vibración, fricción y estiramiento repetido.
 - . **Acuagénica:** contacto con agua, independientemente de temperatura.
 - . **Colinérgica:** calor, ejercicio intenso, estrés.
 - . **Contacto:** agentes físicos, temperatura, estrés, etc.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la urticaria es fundamentalmente clínico (exhaustiva historia clínica), con la realización de escasas pruebas complementarias, más orientadas al tipo de urticaria y su desencadenante que al propio diagnóstico en sí. Las fases clásicas serían:

Anamnesis

Consiste en la realización de la historia clínica personal, que incluya:

- Antecedentes personales y familiares de urticaria y atopia (incluyendo alergias alimentarias).

- Antecedentes personales de otras enfermedades (infecciones, procesos inflamatorios, problemas digestivos, enfermedades psicosomáticas, estrés, implantes quirúrgicos), tratamientos previos y actuales (AI-NE, hormonas, laxantes, inmunizaciones...).
- Factores y posibles situaciones desencadenantes de los brotes que refiera el paciente: alimentos, medicamentos, estímulos físicos, síndrome menstrual...
- Sintomatología del paciente, que incluya los siguientes aspectos: habones (morfología, tamaño, localización y distribución), angioedema; asociación con prurito, dolor, quemazón...
- Frecuencia y duración de las lesiones, variación diurna, relación con vacaciones, viajes, etc.
- Sintomatología sistémica: cefalea, hipotensión, astenia, fiebre, artralgias, disnea, tos, dolor torácico...
- Hábitos tóxicos (alcohol, tabaco, otros) y ocupaciones (profesional, aficiones).

Exploración física

Se debe realizar una exploración física básica. Además, debe realizarse una visualización de toda la superficie cutánea donde existan lesiones, categorizando las mismas y ubicándolas, ya que la exploración física va dirigida fundamentalmente a identificar la lesión característica: el habón y el angioedema.

Pruebas complementarias

La urticaria aguda generalmente no requiere un estudio diagnóstico, ya que suele ser autolimitada.

La única excepción es la sospecha de urticaria aguda debido a una alergia alimentaria o a otros desencadenantes como los fármacos.

En el caso de la urticaria crónica, aunque son de escasa utilidad, sí se recomienda ampliar estudios con pruebas de laboratorio, habitualmente hemograma y PCR o VSG.

Únicamente si los hallazgos de la historia clínica y el examen físico son muy sugestivos, se podrían solicitar otras pruebas para la identificación de posibles factores desencadenantes: inmunoglobulina E (IgE) total, determinaciones microbiológicas (*Helicobacter pylori*, *Anisakis*), hormonas tiroideas, anticuerpos antitiroideos, anticuerpos antinucleares (ANA), test del suero autólogo (urticaria autoinmune), test de presión (urticaria por presión), test de cubo de hielo (urticaria por frío), provocación con vórtex (urticaria vibratoria), test de provocación con ultravioleta (UV) (urticaria solar), dermografómetro (dermografismo sintomático), contacto con gasa húmeda (urticaria acuagénica), ejercicio (urticaria colinérgica), test epicutáneos (urticaria de contacto).

La biopsia cutánea no es necesaria en la mayoría de casos y debe considerarse solo ante sospecha de vasculitis, enfermedad autoinflamatoria u otra condición inmunológica que pueda presentarse con lesiones similares (penfigoide ampolloso, etc.).

Diagnóstico diferencial

Debemos realizar un diagnóstico diferencial a destacar:

- **Anafilaxia:** rápida progresión cutánea acompañada de afectación de otros órganos.
- **Toxicodermias:**

—**Inmediatas:** urticaria, progresión a anafilaxia.

—**Retardadas:** SSJ/NET (antecedente toma de fármacos 3-6 semanas; fiebre, erosiones en mucosas, lesiones ampollosas; signo de Nikolsky positivo), DRESS (fiebre, adenopatías y afectación pulmonar, renal y hepática).

- **Urticaria-vaculitis:** lesiones habonosas más dolorosas que pruriginosas, con duración mayor de 24 horas, dejan lesión residual y no responden a tratamiento corticoideo. Asocian poliartralgias y fiebre.
- **Angioedema no histaminérgico (mediado por bradicininas):** angioedema sin afectación cutánea. Hereditario, adquirido o inducido por IECAS. No respuesta a tratamiento con anti-H1, corticoides o adrenalina.
- **Dermatitis de contacto:** local, no afectación generalizada. Exposición previa.
- **Alergia picaduras/alimentos:** exposición previa. Progresión anafilaxia.
- **Patología autoinmune tiroidea (enfermedad de Hashimoto):** edema palpebral/periorbicular sin afectación mucosa. Signos clínicos de patología tiroidea.
- **Eritema solar polimorfo:** eritema, pápulas, placas o vesículas pruriginosas en áreas fotoexpuestas. Inicio entre

30 minutos-6 horas tras exposición. Exposición solar previa.

- **Penfigoide ampolloso:** lesiones urticariformes, muy pruriginosas, que evolucionan a ampollas. Tronco y flexoras. Nikolsky negativo.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la urticaria depende de la gravedad de la reacción y la rapidez de su evolución. La clínica asociados a tener en cuenta será:

- Signos y síntomas de rápida aparición o progresión.
- Dificultad respiratoria o distress respiratorio: taquipnea, hipoxemia hasta cianosis.
- Presencia de broncoespasmos (sibilancias).
- Disfonía/afonía, sialorrea y estridor por edema laríngeo.
- Puede presentar vómitos, hipotensión, confusión, somnolencia, síncope hasta el coma.

El tratamiento inicial de la urticaria aguda con o sin angioedema se debería enfocar en el alivio a corto plazo del prurito, de los habones y del angioedema si está presente. Aproximadamente dos tercios de los casos de urticaria aguda se resuelven espontáneamente.

Con respecto a la urticaria crónica, el enfoque terapéutico puede implicar la identificación y eliminación de causas subyacentes, la evitación de factores desencadenantes, la inducción de tolerancia y/o el uso de tratamiento farmacológico para prevenir la liberación de los mediadores de mastocitos y/o los efectos de éstos.

Para eliminar la causa subyacente se necesita conocer cuál es dicha causa y esto no siempre es fácil.

En el caso de los fármacos, cuando se sospeche que son estos los causantes, deben de omitirse por completo o sustituirse por otra clase de fármacos si son imprescindibles.

Es aconsejable evitar los estímulos físicos para el tratamiento de las urticarias físicas y por presión, pero a veces también es complicado de lograr.

En cuanto al tratamiento farmacológico, en aquellos pacientes que sólo tienen síntomas cutáneos sin angioedema, los antihistamínicos orales suelen ser suficientes. En función de la gravedad o si se asocia angioedema se utilizarán también los glucocorticoides, a veces administrados por vía intravenosa.

En casos graves, con afectación respiratoria o cardiovascular, la prioridad es asegurar la vía aérea superior y la adrenalina representa la base del tratamiento. Todos los casos con afectación laríngea deben de ser considerados una urgencia médica, y si hay signos de compromiso importante de la vía aérea se debe valorar la intubación.

En cuanto a la adrenalina, a pesar de no ser un tratamiento indicado para la urticaria aguda, ante episodios de sospecha de anafilaxia que podrían iniciarse con urticaria, estaría indicado su uso. La dosis (ampollas de dilución 1:1000) es de 0.3-0.5 ml administradas por vía intramuscular en la cara lateral externa del muslo, que puede repetirse cada 5-15 minutos según sea necesario hasta una dosis máxima de 1.5 ml.

A modo de resumen, los pilares en el tratamiento de la urticaria y el angioedema son las medidas generales (evitación de desencadenantes) y como tratamiento farmacológico en la fase aguda los antihistamínicos y los glucocorticoides.

Antihistamínicos

En la urticaria aguda se administran por vía sistémica en el Servicio de Urgencias y posteriormente se prescriben domiciliariamente de forma continua hasta que el paciente se encuentre al menos 7-10 días libre de síntomas. De esta forma se disminuye el riesgo de recidivas o la cronificación.

Los antagonistas de receptores H1 controlan por lo general la mayoría de los casos de urticaria y el prurito. Los de primera línea terapéutica de elección son los anti-H1 de segunda generación no sedante como la loratadina (10-20 mg/día), la desloratadina (5 mg/día) o la fexofenadina (120-180 mg/día). También son muy utilizados otros con poca capacidad sedante como la cetirizina (10 mg/día) o la levocetirizina (5mg/día). Otros antagonistas de receptores H1 utilizados, aunque con mayor capacidad sedativa, son la clorfeniramina o la difenhidramina.

En el caso de que no haya mejoría con estas dosis, la recomendación es incrementar la dosis hasta un máximo que se establece en el cuádruplo de la dosis estándar. Se debe esperar entre 1-4 semanas para comprobar la efectividad.

Si aún así resultan ineficaces en el control de los síntomas, se puede añadir un antagonista de receptores H2 como la cimetidina, la ranitidina o la famotidina.

Otra posibilidad es utilizar la doxepina, un antidepresivo tricíclico que posee actividad antagonista de los receptores H1 y H2. Es útil sobre todo en casos de urticaria intensa acompañada de síntomas afectivos.

En los casos de urticaria crónica, el problema es que el cese de estos tratamientos suele originar una recidiva. En este caso o en caso de ineficacia se podría utilizar la ciproheptadina en dosis iniciales de 8 mg, que se aumentan hasta llegar a 32 mg/día y en particular la hidroxizina con dosis iniciales de 40 mg que se aumentan hasta llegar a 200 mg/día.

Glucocorticoides

Los glucocorticoides tópicos no tienen utilidad en la urticaria (con la posible excepción de la urticaria por presión en las plantas de los pies como terapia alternativa con escasa evidencia). Es preferible no administrar aquellos de presentación sistémica en urticarias idiopáticas, inducidas por alérgenos o urticarias físicas para evitar sus efectos secundarios a largo plazo.

Los glucocorticoides de acción general se utilizan en las urticarias agudas con angioedema, en las urticarias por presión o vasculíticas (en particular con participación de eosinófilos), en el angioedema idiopático con o sin urticaria o en la urticaria crónica que no mejora con el tratamiento habitual.

Existe una fuerte recomendación contra el uso a largo plazo de corticoesteroides. Se aconseja su uso en ciclos cortos y pautas descendentes, normalmente prednisona a dosis de 0.5 mg/kg/día, aunque no está establecida una dosis determinada.

En el caso de episodios agudos intensos o exacerbaciones graves de urticaria crónica (especialmente cuando se acompaña de angioedema) se suele indicar un ciclo corto de corticoesteroides orales (prednisona a dosis de 30-60 mg/día en pauta descendente durante hasta un máximo de 10 días). Con esto se reduce la duración y la actividad de la enfermedad.

Otros fármacos

Pueden utilizarse ante la refractariedad con los anteriores y ya no en el momento urgente son los siguientes:

Omalizumab: Es un Ac monoclonal contra IgE. Se recomienda la agregación a los antihistamínicos en los pacientes con urticaria crónica que no responden a antihistamínicos H1 de segunda generación. Ha demostrado ser muy eficaz y seguro en el tratamiento de la urticaria espontánea. Previene el desarrollo de angioedema, mejora notablemente la calidad de vida y es adecuado para el tratamiento a largo plazo. La dosis establecida es de 150-300 mg cada 4 semanas (siendo la dosificación independiente de la IgE sérica total). También es eficaz en la urticaria inducida (urticaria solar, urticaria por frío, urticaria colinérgica...).

Ciclosporina A: No está autorizada para la urticaria y se recomienda solo para pacientes con enfermedad grave (urticaria idiopática crónica o autoinmunitaria crónica intensa) resistente a cualquier dosis de antihistamínico y omalizumab en combinación o si éstos están contraindicados o no recomendados por los efectos adversos. No se puede recomendar como tratamiento estándar debido a una alta incidencia de efectos adversos.

Montelukast: Es un antagonista del receptor de leucotrienos CysLT1. Se podría agregar al tratamiento con antihistamínicos en dosis de 10 mg/día. De todos modos, el nivel de evidencia de la eficacia de los antagonistas de los receptores de leucotrienos en la urticaria es bajo.

Antagonistas de TNF-alfa e Ig IV: Los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa y las Ig IV se recomiendan actualmente solo como última opción (el anti TNF-alfa para urticaria por presión retardada y las Ig IV para la urticaria crónica espontánea).

BIBLIOGRAFÍA

- Zuberbier T, Aberer W, Asero R, et al. The EAACI/GALEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy. 2018.
- Hospital Universitario 12 de Octubre. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 8a ed. Madrid; 2016
- Wolff K, Johnson R, Saavedra A, Fitzpatrick. Atlas de Dermatología clínica. 7a ed. México: Mc Graw Hill; 2014.

SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON Y NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA

Pablo Chicharro, Pedro Rodríguez-Jiménez, Ester Muñoz-Aceituno.

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) son cuadros infrecuentes, pero que pueden tener una elevada mortalidad. Se diferencian clínicamente en el porcentaje de superficie corporal afectada, con un incremento proporcional de la mortalidad. Ambos son más frecuentes en mujeres y pacientes inmunocomprometidos. En la mayoría de los casos están desencadenados por un agente farmacológico, especialmente en la NET, siendo los más frecuentes: alopurinol, antibióticos, AINEs y anticonvulsivantes. El riesgo es máximo en la primera semana de tratamiento. Tras la exposición al fármaco, se desencadena una reacción de hipersensibilidad con la apoptosis masiva de queratinocitos que provoca la necrólisis epidérmica responsable del cuadro clínico.

Los síntomas iniciales suelen consistir en fiebre, sensación de cuerpo extraño ocular y odinofagia, que preceden de 1 a 3 días a la afectación cutánea. Las lesiones suelen iniciarse como máculas eritemato-violáceas, con tendencia a la coalescencia, afectando al tronco, con extensión progresiva cefálica y a región proximal de extremidades. Las palmas y plantas también pueden afectarse y hacerlo de forma temprana. Las lesiones progresan hacia máculas de coloración grisácea en horas o días, con formación paralela a la necrosis de ampollas flácidas, frágiles y con signo de Nikolsky positivo, otorgando un aspecto de piel escaldada. En la mayoría de los pacientes hay eritema y erosiones de mucosa orogenital y oculares, siendo la afectación de mucosas muy dolorosa. Además de la fiebre, entre las manifestaciones sistémicas se incluyen: tos, disnea, dolor abdominal, diarrea y adenopatías.



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de SSJ y NET es fundamentalmente clínico. Ante la aparición de lesiones cutáneas compatibles, afectación de mucosas y la introducción reciente de fármacos sospechosos, debemos establecer la sospecha clínica y no postponer el resto del abordaje diagnóstico-terapéutico. Según el porcentaje corporal afectado tendremos tres categorías:

- 1) Menos del 10%: SJS.
- 2) 10-30%: Solapamiento SJS/NET.
- 3) Más del 30%: NET. Una mayor afectación implica un peor pronóstico y, por lo tanto exige un abordaje más agresivo.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico es clínico y se confirma con la biopsia cutánea, dentro del diagnóstico diferencial se encuentra:

- Eritema multiforme

- Transtornos ampollosos primarios
- Eritemas infecciosos tóxicos
- Enfermedad de Kawasaki
- Dermatitis exfoliativa

Pruebas complementarias

En el estudio complementario inicial se debe incluir:

- Hemograma (descartar citopenias)
- Coagulación (coagulopatía de consumo)
- Bioquímica (valoración de función renal, hidroelectrolitos, colestasis y citólisis). Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR.
- Radiografía de tórax postero anterior y lateral. Si hay sintomatología respiratoria, se debe realizar una radiografía de tórax ante el riesgo de progresión a distrés respiratorio.
- Ingresado en planta/UCI. El estudio histopatológico será de confirmación, mostrando necrosis de queratinocitos epidérmicos, con formación de ampollas subepidérmicas y con inmunofluorescencia negativa.



TRATAMIENTO

El tratamiento de ambos cuadros, fundamentalmente de la NET, debe ser inmediato ante la sospecha diagnóstica y seguirá las mismas premisas que el de grandes quemados. En primer lugar y si conocemos el fármaco responsable, se procederá a su retirada. Si la superficie corporal afectada es mayor al 20%, se recomienda el manejo en una unidad de cuidados intensivos. Se debe realizar un adecuado aporte volémico, con corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas. Se prestará especial atención al riesgo de sobreinfección bacteriana, aplicando antibióticos tópicos de forma profiláctica (mupirocina o ácido fusídico) e instaurando antibioterapia sistémica precozmente si hay datos de sobreinfección, previa toma de cultivos. En el cuidado tópico se pueden realizar lavados con soluciones de suero salino isotónico, aplicando posteriormente vaselina no perfumada, especialmente en zonas de presión. Se manipulará mínimamente al paciente y bajo medidas tan asépticas como sea posible. Puede ser necesaria la valoración especializada oftalmológica y el empleo de colirios antibióticos. Respecto a tratamientos específicos no existe ninguna evidencia establecida, con una alta controversia respecto al empleo de corticoides. Si se considera su empleo, se recomiendan pulsos cortos de 3 días con dexametasona (1,5mg/kg/día). El empleo de inmunoglobulinas intravenosas también puede frenar la progresión de la enfermedad (>2g/kg dosis total, repartida en 3-4 días).

ALERTA

- Debido a su elevada mortalidad, ésta es una auténtica emergencia dermatológica. No debemos retrasar el tratamiento y las primeras pruebas complementarias en un paciente que presenta lesiones cutáneas

compatibles, lesiones en mucosas u oculares, y un antecedente farmacológico reciente.

BIBLIOGRAFÍA

- Lerch M, Mainetti C, Terzioli Beretta-Piccoli B, Harr T. Current perspectives on Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. Clin Rev Allergy Immunol. 2018;54(1):147-176.
- Dodiuk-Gad RP, Chung WH, Valeyrie-Allanore L, Shear NH. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: an update. A J Clin Dermatol. 2015;16(6):475-93.
- Downey A, Jackson C, Harun N, Cooper A. Toxic epidermal necrolysis: review of pathogenesis and management. J Am Acad Dermatol. 2012;66(6):995-1003.

DERMATOSIS AMPOLLOSAS

María Jesús Suarez valladares

INTRODUCCIÓN

Una historia clínica bien orientada y un examen físico adecuado van a ser cruciales para identificar el origen de las lesiones y poder plantear un correcto tratamiento.

A continuación hablaremos de las enfermedades ampollas, que agrupan un conjunto de patologías muy distintas, la mayoría de causa autoinmune, que tienen en común la formación de ampollas. Estas ampollas ocurren por un despegamiento de la epidermis por la formación de anticuerpos contra las proteínas que intervienen en las uniones intercelulares.

En la tabla se muestran algunas de las enfermedades cutáneas que cursan con ampollas o vesículas que, más frecuentemente, podemos observar en urgencias.

- La aparición de ampollas o vesículas en un paciente pueden tener múltiples causas, lo más importante es realizar una historia clínica exhaustiva que nos oriente hacia el posible origen de las lesiones.
- Hay que prestar especial importancia a la ingesta de fármacos nuevos, historia de traumatismos o quemaduras, edad del paciente, localización, distribución (piel y/o mucosas) y presencia de síntomas acompañantes.
- Es necesario realizar una biopsia diagnóstica (incluso previo a la instauración de tratamiento) a todas las enfermedades ampollas para identificarlas y poder tratarlas correctamente.
- Se puede manejar con corticoides tópicos, dejando los tratamientos sistémicos para pacientes con un diagnóstico de certeza o brotes muy extensos.

Datos clínicos	Posible diagnóstico	Manejo
¿Placas con ampolla en periferia? ¿Diseminación rápida? ¿Costra color miel?	Impétigo ampollar	Antibiótico tópico en formas localizadas u oral si extenso
¿Vesículas agrupadas en racimo? ¿Mucosa oral o genital/nariz/lumbo-sacra? Recurrencias	Infección VHS (virus herpes simple)	Antivírico sistémico si importante extensión. Tratamiento profilaxis si > 1 brote/mes
¿Dolor? ¿Placa eritemato-edemaosa + vesículas agrupadas? ¿Trayecto metamérico?	Herpes Zóster	Antivírico sistémico (72h iniciales) Sulfato de Zinc. Afectación punta nasal u ojo, derivar OFTALMOLOGÍA
¿Prurito incoercible de predominio nocturno? ¿Afectación convivientes? ¿Excoriaciones por rascado? ¿Vesículas y surcos interdigitales?	Escabiosis	Permetrina 5% (repetir a la semana) Tratamiento convivientes y fómites
¿Fármacos? ¿Exantema inicial? ¿Mal estado general?	Síndrome Stevens-Johnson / Necrolisis epidérmica tóxica	Urgencias especialista dermatología +/- UCI.
¿Vesículas claras en laterales de dedos o plantas? ¿Prurito intenso? ¿Recidiva de brotes?	Eccema dishidrótico	Corticoide tópico de alta potencia (noches oclusión) Reducir sudoración.
¿Edad avanzada? ¿Fármacos? ¿Neoplasia? ¿Afectación de mucosa oral?	Enfermedades ampollas autoinmunes (Pénfigo – Penfigoide)	Derivar al dermatólogo

DIAGNÓSTICO

Enfermedades ampollas autoinmunes

Pénfigo

El pénfigo es una enfermedad producida por la formación de unos anticuerpos (IgG) contra las desmogleinas 1 y 3 de la epidermis provocando una formación de ampollas que pueden afectar a mucosa oral y piel.

Son unas ampollas intraepidérmicas flácidas (que se rompen fácilmente) sobre piel sana y típicamente presentan un

signo de Nikolsky positivo (despegamiento de la piel sana por fricción).

El diagnóstico es clínico pero precisa una biopsia de confirmación, además de identificar la presencia de anticuerpos anti desmogleína I y III en sangre (los más frecuentes).

La forma más frecuente es el pénfigo vulgar, que suele iniciar con lesiones en mucosas (Figura 1b) y posteriormente extenderse al resto del cuerpo (Figura 1a). Existen otros tipos menos graves como el superficial, el gravídico o el desencadenado por fármacos.

Ante un paciente en urgencias con sospecha de pénfigo, lo más importante es la reposición hidroelectrolítica y evitar la sobreinfección, ya que se trata de pacientes con grandes áreas denudadas. El tratamiento de elección inicial serán los corticoides de alta potencia tópicos en formas localizadas u orales en casos extensos (siempre que sea posible tras la tener una confirmación histológica).



Figura 1a. Áreas denudadas extensas en las extremidades y torax de un paciente con pénfigo vulgar. 1b. Afectación oral del pénfigo con ampollas y áreas denudadas en mucosa.

Penfigoide ampollosa

Se trata de una entidad frecuente en personas mayores, donde hay una producción de anticuerpos anti-bp180 dirigidos contra los hemidesmosomas de la membrana basal epidérmica. Clínicamente los pacientes refieren intenso prurito con la posterior formación de ampollas tensas sobre una piel eritematosa. No tienen signo de Nikolsky y no suele afectar a mucosas. Para su diagnóstico se precisa una biopsia de confirmación con inmunofluorescencia directa para identificar depósitos de IgG y C3 en membrana basal).

Cursa en brotes y suelen responder a los tratamientos tópicos con corticoides de alta potencia. En ocasiones se pueden asociar antihistamínicos orales para el control del prurito. Su pronóstico es más favorable que el pénfigo.



Figura 2. Ampollas tensas sobre piel sana en extremidad inferior de un paciente con un penfigoide ampollosa. Las lesiones suelen ser muy pruriginosas.

Penfigoide del embarazo o Herpes Gestationis

Es una enfermedad poco frecuente típica de mujeres embarazadas que puede iniciarse como un prurito en las primeras semanas del embarazo para dar paso a unas ampollas de predominio periumbilical y zonas proximales de

extremidades. No suele existir afectación mucosa. El cuadro tiende a mejorar las últimas semanas del embarazo y empeorar 3-4 meses después del parto. El cuadro se puede repetir en posteriores embarazos con una presentación precoz y más severa. Para su diagnóstico es importante tomar una biopsia que confirme la presencia de anticuerpos en membrana basal. El manejo durante el embarazo será con corticoides tópicos y antihistamínicos orales, reservando otros fármacos para el periodo del puerperio.

Dermatitis herpetiforme

Es una enfermedad autoinmune frecuentemente asociada a enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Se caracteriza por lesiones tipo vesícula muy pruriginosas con una distribución simétrica en glúteos, codos, sacro, rodillas... muchas veces solo se aprecian escoriaciones. No suele afectar a mucosas. El tratamiento consiste en realizar una dieta exenta de gluten y sino se controla asociar sulfonas.

Otras enfermedades ampollas

Virus Herpes

Tanto el herpes simple como el varicela-zóster pueden formar lesiones vesiculosas de diferente distribución según el organismo implicado, además se pueden acompañar de un pródromo e intenso dolor. Se debe de manejar con antivirales orales.

Impétigo Ampolloso

Es una infección causada por el *Staphylococcus Aereus*, que causa unas ampollas flácidas de contenido purulento que rápidamente se rompen dejando erosiones superficiales. Suele afectar a zonas periorificiales y afectar a convivientes. Su tratamiento es con antibióticos orales.

Enfermedad Mano-Pie-Boca

Infección por Coxsackie que típicamente afecta a bebés y niños pequeños con sintomatología general de fiebre, dolor faríngeo y lesiones ampollas en manos y pies.

Traumatismos

Ampollas causadas por quemaduras o por un apoyo prolongado de personas que permanecen inmóviles durante mucho tiempo, suelen ser la base de las úlceras.

Eccemas

Cuando los eccemas son muy agudos pueden presentar ampollas y/o vesículas con contenido seroso. Aparece típicamente en los eccema dishidróticos

Fitofotodermatitis

Existen algunas plantas (higuera o cítricos) que pueden sensibilizar la piel tras el contacto con ellas, provocando que una exposición solar cause lesiones tipo quemadura con formación de ampollas.

Toxicodermias

Algunas reacciones cutáneas a fármacos pueden provocar ampollas, entre ellas debemos diferenciar el eritema exudativo multiforme, el síndrome de Steven-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. Todos precisan de un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar complicaciones con fatal desenlace.

TRATAMIENTO

Recomendaciones prácticas en urgencias ante un paciente con lesiones ampollas.

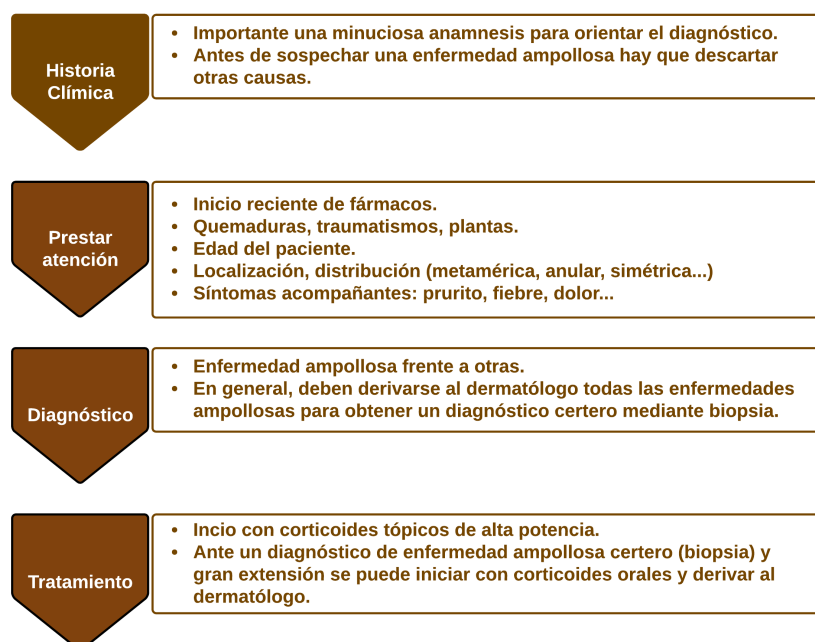


Figura 3. Algoritmo de manejo en urgencias ante un paciente con lesiones ampollosas

BIBLIOGRAFÍA

- Kershenovich R, Hodak E, mimouni D. Diagnosis and classification of pemphigus and bullous pemphigoid. Autoimmun Rev. 2014;13(4-5):477-81.
- Sánchez-Pérez J, García-Diez A. Pénfigo. Actas Dermosifiliogr. 2005;96(6):329-56.
- Suárez-Fernández R, España-Alonso A, Herrero-González JE, Mascaró-Galy JM. Manejo práctico de las enfermedades ampollosas autoinmnes más frecuentes. Actas Dermosifiliogr. 2008;99(6):441-55.

ERITEMA MULTIFORME.

Pedro Rodríguez-Jiménez, Pablo Chicharro, Alejandra Reolid

INTRODUCCIÓN

El eritema multiforme (EM) es un síndrome autolimitado agudo, de intensidad leve o moderada y que tiende a la recurrencia en al menos el 30% de pacientes. Aparece en todas las edades, siendo más frecuente en adolescentes y personas jóvenes y raro en niños y ancianos. El síndrome normalmente se relaciona con una infección aguda, siendo en más de la mitad de los casos el culpable el virus del herpes simple (VHS). La segunda causa más frecuente y la primera en casos pediátricos la infección por *M.pneumoniae*. La causa farmacológica es infrecuente y normalmente se tratan de reacciones adversas a medicamentos con una morfología "EM-like". Por otro lado, hablaremos de:

- EM menor cuando aparecen lesiones cutáneas sin lesiones mucosas y
- EM mayor cuando estas últimas si están presentes, lo que ocurre en aproximadamente el 70% de pacientes.

DIAGNÓSTICO

El EM se define por sus características clínicas: lesiones en placa con morfología en diana con o sin ampolla central, con un eritema de color vivo o un tinte purpúrico y con un predominio de afectación en cara y región acral de extremidades que aparecen en pocos días. Los pacientes con afectación mucosa presentan erosiones en labios y mucosa oral y afectación de la mucosa ocular, nasal, uretral y anal puede ocurrir. Un tercio de pacientes presenta fiebre franca en el momento del brote de las lesiones y estos pacientes suelen asociar linfadenopatías cervicales. No hay alteraciones analíticas específicas en el EM, pudiendo encontrarse leucocitosis, elevación de reactantes de fase aguda y de transaminasas. Si existe sintomatología respiratoria, una radiografía de tórax y una PCR para *M. pneumoniae* deberían realizarse solo en el caso de dudas diagnósticas (con otros procesos ampollosos, urticaria, síndrome de Sweet o vasculitis) se realizará una biopsia que mostrará un infiltrado de linfocitos en la unión dermo-epidérmica junto con ligera necrosis de la epidermis, lo que lo suele permitir la diferenciación del espectro de lesiones del síndrome de Stevens-Johnson/Necrosis Epidérmica Tóxica donde la necrosis epidérmica es muy pronunciada.



TRATAMIENTO

Las lesiones son autolimitadas y curan sin secuelas por lo que el objetivo del tratamiento es el alivio sintomático y la reducción de la duración de la sintomatología.

- **Corticoides sistémicos.** El uso sistemático de corticoides sistémicos, pese a su controversia en cuanto a las complicaciones infecciosas, está recomendado en pacientes con lesiones de intensidad moderada o grave a

dosis de 0.5-1 mg/kg en pauta corta de 5-7 días.

- **Anestésicos tópicos.** Para las lesiones orales los anestésicos y los corticoides tópicos proporcionaran alivio sintomático. En estos pacientes es fundamental evaluar si las lesiones orales impiden la alimentación per oris de cara a valorar ingreso.



Las lesiones de EM aparecen después de la infección por VHS, con una media de 7 días tras el brote, y por tanto no se recomienda el tratamiento antivírico en el momento agudo, sin embargo, la terapia supresora es efectiva para prevenir las recurrencias al disminuir los episodios de infección por VHS. En raras ocasiones el brote de VHS puede aparecer a la vez que el brote de EM o después, pudiendo iniciarse en ese momento tratamiento antivírico tras demostrar la infección con una muestra para PCR que mostrará el resultado en 24 horas.

PUNTO ALERTA

- El diagnóstico del EM es clínico y solo ante la duda con otros procesos deben realizarse exploraciones complementarias.
- El tratamiento es sintomático, con corticoides orales a dosis de 0.5mg/kg durante 5 días, utilizándose el Aciclovir solo para la prevención de futuros brotes y no de manera general en el tratamiento agudo.

BIBLIOGRAFÍA

- Auquier-Dunant A, Mockenhaupt M, Naldi L, Correia O, Schöder W, Roujeau J. SCAR Study Group. Severe Cutaneous Adverse Reactions. Correlations between clinical patterns and causes of erythema multiforme majus, Stevens-Johnson Syndrome and toxic epidermal necrolysis: results of an international prospective study. Arch Dermatol. 2002;138(8):1019-24.
- Weston WL. Herpes-associated erythema multiforme. J Invest Dermatol. 2005;124(6):XV-XVI.
- Wetter DA, Davis MD. Recurrent erythema multiforme: Clinical characteristics, etiologic associations, and treatment in a series of 48 patients at Mayo Clinic, 2000 to 2007. J Am Acad Dermatol. 2010;62(1):45-53.

LIQUEN PLANO

María Jesús Suarez Valladares

- El liquen plano es un trastorno autoinmunitario poco frecuente de causa desconocida.
- Se identifican las 5 P: pequeñas placas o pápulas brillantes, poligonales, pruriginosas, de color violáceo-púrpura. Son características unas líneas blancas superficiales denominadas estrías de Wickham.
- Suelen aparecer en muñecas y tobillos. Existen otros patrones que afectan a mucosas o al cuero cabelludo.
- Cursa en brotes y puede tener una resolución espontánea. Lo más habitual es el manejo con corticoides tópicos.

INTRODUCCIÓN

El liquen plano es una enfermedad inflamatoria crónica, poco frecuente, que ocupa el 1% de las consultas dermatológicas. Lo más frecuente es su presentación en la piel, aunque puede afectar también a mucosas (oral o genital).

El origen de la enfermedad radica en una alteración inmunológica donde los linfocitos T atacan a las células de la epidermis provocando esas lesiones inflamatorias. Parece que los brotes pueden estar relacionados con episodios de estrés o ansiedad, algunos fármacos o la infección por una hepatitis C.

DIAGNÓSTICO

Las manifestaciones del liquen plano son bastante típicas por lo que, con un examen cutáneo adecuado y un interrogatorio completo no debería ser necesario llegar a una biopsia que confirme el diagnóstico.

El cuadro típico es un paciente que de forma repentina desarrollan pápulas y placas poligonales de pequeño tamaño, de un característico color violáceo o purpúrico, muy pruriginosas. Es muy característico la aparición de unas pequeñas líneas blancas superficiales en forma de red, conocidas como estrías de Wickham. Suelen afectar a la cara interior de las muñecas, tobillos o parte inferior de la espalda, aunque de forma progresiva se pueden generalizar al tronco y resto de extremidades. (Figura 1)

Hasta en un 50% de las veces pueden tener una afectación de mucosas a nivel lingual, boca y genital. Cuando las lesiones aparecen en mucosa oral se observan unas líneas blanquecinas, eritematosas o erosivas que pueden ocasionar molestias a la hora de ingerir alimentos y que en un porcentaje muy bajo podrían tornar a una lesión maligna. (Figura 2)

Cuando la inflamación causada por el liquen afecta a los folículos pilosos, podemos observar una alopecia parcial o total en la zona con discreto eritema perifolicular y punteado de queratosis característico. Generalmente la pérdida de cabello es irreversible. También, hasta en un 15% de los pacientes existe afectación ungueal que suele provocar la atrofia de la uña (Figura 2).

Otros patrones podrían ser el liquen plano anular, atrófico, hipertrófico, ampollar, pigmentoso, actínico o ungueal.

Cuando se confirma el diagnóstico es recomendable descartar una posible asociación a infecciones víricas (mediante serologías), toma de fármacos o clínica.



Figura 1. Localización típica de lesiones por liquen en muñecas y tobillos. En la última fotografía se puede apreciar con más detalle las típicas pápulas planas poligonales de color violáceo.



Figura 2. Otras localizaciones menos frecuentes pueden ser la mucosa oral, donde se aprecia el típico reticulado blanquecino. Cuando el liquen afecta a las uñas se observa un adelgazamiento y fragilidad ungueal (onicorrexis) y un despegamiento distal (onicoquiasis).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento dependerá de la extensión y sintomatología causada. En muchas ocasiones como ya hemos destacado, cursa en brotes con una duración autolimitada.

- **Corticoides tópicos.** En las formas localizadas, que son las más frecuentes, se puede controlar con corticoides tópicos potentes en crema o emulsión dependiendo de la extensión, la posología adecuada sería aplicar 2 veces al día hasta resolución de lesiones y prurito y posteriormente 1 vez al día durante una semana más para disminuir el riesgo de recidiva.
- **Derivados de la vitamina A.** También es posible combinar los corticoides tópicos con derivados de la vitamina A (tretinoína) tópicos para ahorrar el uso de los corticoides, especialmente cuando las lesiones presentan una hiperqueratosis o escama acusada.
- **Antihistamínicos orales.** Si el paciente presenta mucho prurito se pueden añadir antihistamínicos orales para conseguir un mejor control.
- **Corticoides orales o retinoides orales.** Cuando la enfermedad es más generalizada o no responde al primer escalón de tratamiento, lo más adecuado es derivar a un dermatólogo. En estos casos, se pueden emplear tratamientos sistémicos como los corticoides orales o retinoides orales.
- **Fototerapia.** También es útil la fototerapia (rayos UVA) o el metotrexato.

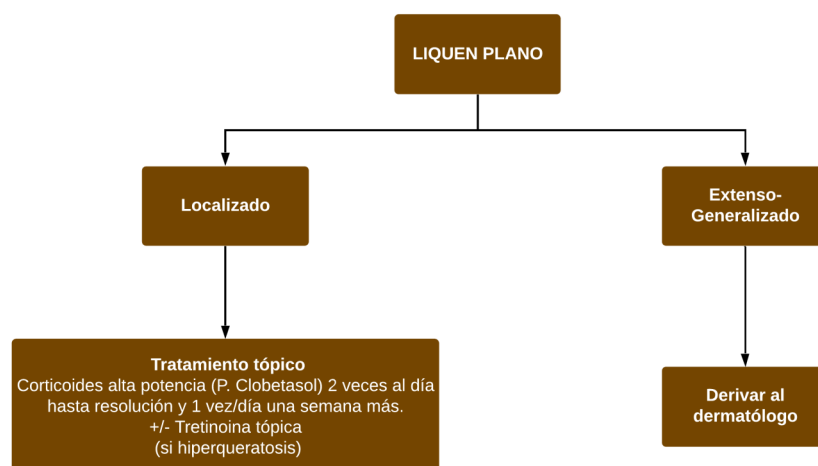


Figura 3. Algoritmo de tratamiento en urgencias de liquen plano según extensión de las lesiones

BIBLIOGRAFÍA

- Rodríguez Acar M, Carbajal Pruneda P. Liquen plano. Revisión de la literatura. Rev Cent Dermatol Pascua 2006.15(3):203-208.
- Usatine RP, Tinitigan M. Diagnosis and treatment of lichen planus. Am Fam Physician. 2011;84(1):53-60.
- Boyd AS, Neldner KH. Lichen planus. J Am Acad Dermatol. 1991;25(4):593-619.
- Pittelkow M, Daoud MS. Lichen planus. En: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Lelfell DJ, Wolff K. Fitzpatrick Dermatología en Medicina General. 7º ed. Madrid: Médica Panamericana;2009. p.244-55.
- Kwar AJ, De D. Methotrexate for treatment of lichen planus: old drug, new indication. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013; 27(3):e410-13.

ECCEMA

Samsara López Hernández, Raúl López Izquierdo.

INTRODUCCIÓN

El término eccema hace referencia a un patrón clínicopatológico de inflamación cutánea debido a múltiples causas, siendo la espongiosis la lesión histológica más característica.



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del eccema se basa en las manifestaciones clínicas características como son: el prurito que puede ser de intensidad variable y las lesiones eritematosas en la piel.

En función del tiempo de evolución, se distinguen tres fases sucesivas:

Eccema agudo: Comienza como un eritema y edema localizado en forma de máculas o pápulas con vesículas que suelen ser pequeñas y agrupadas. La rotura de éstas da lugar a un exudado que termina en la formación de una costra.

Eccema subagudo: Predominan las lesiones descamativas.

Eccema crónico: Liquefificación con engrosamiento de la piel, grietas, fisuras, alteraciones en la pigmentación y lesiones de rascado.

Debemos indagar en la anamnesis en los antecedentes personales y familiares del paciente, el tiempo de evolución y la extensión de las lesiones, las regiones afectadas, los antecedentes epidemiológicos (trabajo, deportes, mascotas, plantas) y en los tratamientos realizados previamente y su resultado en el caso de que los hubiese realizado.

Actualmente, se suelen clasificar los eccemas en base a su etiología:

Dermatitis numular: Afecta sobre todo a adultos de ambos sexos entre los 50-70 años y en meses invernales. Se trata de lesiones localizadas, con placas eritematodescamativas redondeadas afectando habitualmente en las piernas y brazos.

Dishidrosis: Aparece en personas con lavados frecuentes de manos. Consiste en vesículas y/o descamación en caras laterales de los dedos de manos y pies, muy pruriginosas.

Dermatitis atópica: Es una enfermedad inflamatoria y pruriginosa de la piel. Suele presentarse con mayor frecuencia en la población infantil aunque no es exclusiva. A menudo hay un aumento sérico de inmunoglobulina IgE y suele asociarse unos antecedentes personales y familiares de atopia. En la edad adulta las lesiones predominan a nivel labial, periocular y perioral, cuello, flexuras y dorso de las manos. Suelen presentar xerosis, manchas descamadas eritematosas, pequeñas vesículas, excoriación, costras y, no infrecuentemente, impetiginización. El diagnóstico se basa en la clínica: picor, distribución típica según la edad, curso en brotes e historia familiar y personal de atopia (asma, rinitis, alergias).

Dermatitis seborreica: Manchas eritematosas con escamas finas de aspecto grasiento, habitualmente en región malar, frente, tórax y cuero cabelludo.

Eccema de contacto irritativo y eccema de contacto alérgico: Los agentes irritantes más frecuentes son los

ácidos o álcalis fuertes y disolventes utilizados con frecuencia en la industria y por el ama de casa.

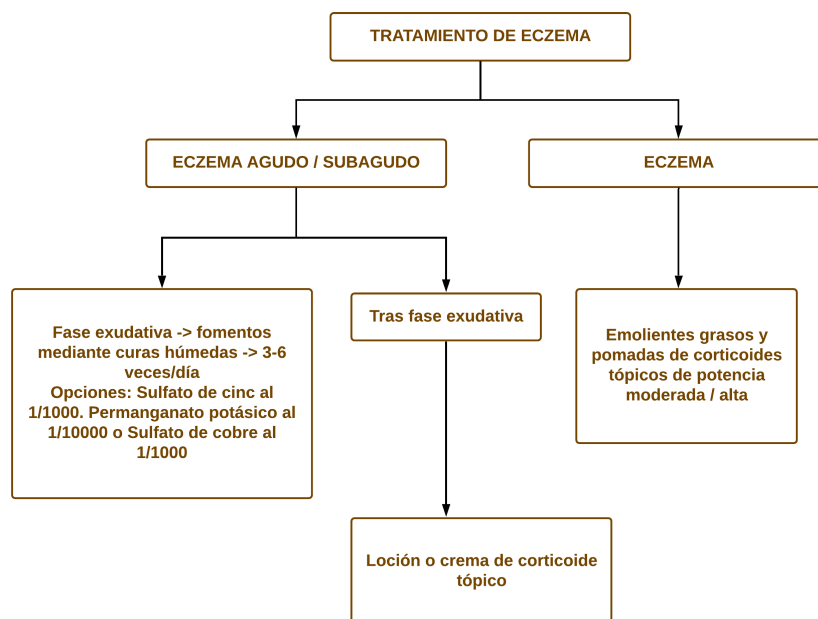
ECCEMA DE CONTACTO IRRITATIVO	ECCEMA DE CONTACTO ALÉRGICO
Mecanismo no inmunológico. Citotóxico directo	Mecanismo inmunológico. Reacción de hipersensibilidad tipo IV
Inicio en minutos/horas	Inicio en horas/días
Localizado sólo en la zona de contacto	Se extiende por la periferia. Puede generalizarse
Bordes bien definidos	Bordes imprecisos
Síntomas asociados: escozor, dolor, quemazón	
Influye el tiempo de contacto y la concentración del irritante	Depende del grado de sensibilización del paciente, con independencia de la concentración del agente
Agua, jabones, disolventes, saliva, orina, ácidos, bases	Metales, cosméticos, fármacos, adhesivos, resinas

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Medidas generales:

- Evitar cambios de temperatura bruscos.
- Evitar el estrés.
- Ducha diaria corta con agua fría. Jabón pH neutro. Secar con suavidad sin frotar.
- Usar ropa amplia y de algodón. Evitar la lana, eliminar etiquetas o costuras, utilizar detergentes suaves y evitar suavizantes.
- Aplicar diariamente crema hidratante tras la ducha y siempre que sea necesario. No usar durante el brote agudo ya que pueden empeorar el cuadro.
- Realizar un buen control del prurito: cortar bien las uñas, hidratación
- Evitar alimentos sólo si existe relación directa con los brotes (demostración clínica y analítica).

Tratamiento específico:



Tratamiento sistémico: en los casos más graves y extensos, pueden utilizarse:

- **Corticoides sistémicos.** Prednisona a 0,5-1mg/Kg/día.
- **Antihistamínicos por vía oral.** Bilastina 20mg 1 cada 24h o Cetirizina 10mg 1 cada 24h durante 7 días. Para aliviar el prurito, está contraindicada la vía tópica.
- **Ansiolíticos.** Se puede indicar el uso de ansiolíticos para disminuir la ansiedad y favorecer el sueño en algún paciente adulto.
- **Antibiótico.** En el caso de que sospechamos sobreinfección bacteriana habría que iniciar tratamiento con antibióticos que cubran tanto al *S. aureus* como el *Estreptococo* betahemolítico del grupo A tales como **Cloxacilina 500mg** 1 cada 6 horas durante 10 días o **Amoxicilina-clavulanico 875/125mg** 1 cada 8 h durante 10 días.

Criterios de derivación a Dermatología son:

- Lesiones generalizadas
- No respuesta a la terapia tópica.
- Sobreinfecciones graves o dudas diagnósticas.
- Dermatitis de contacto en relación con actividad laboral.
- Necesidad de pruebas de contacto.

BIBLIOGRAFÍA

- Lera Imbuluzqueta JM, Bernad Alonso I, Ivars Lleó M, España Alonso A. Dermatitis de contacto. Medicine. 2014;11(48): 2813-22.
- Infante Hernando ML, Serra Baldrich E. Tratamiento del eccema de manos. Mas Dermatol. 2012;17:22-25.
- Lim WH. Eccemas, fotodermatosis, enfermedades papuloescamosas (incluidas las fúngicas) y eritemas figurados. En: Goldman L, Schafel A. Goldman-Cecil. Tratado de Medicina Interna. 25ª Ed. Barcelona: Elsevier; 2016. p. 2662-2671.
- Bielsa Marsol I, Ferrándiz. Dermatología Clínica. 5ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014. p. 91-97.
- Senán Sanz MR, Casanova Seuma JM. Dermatólogo. Eccemas. AMF. 2012;(8):185-196.
- Garavís González JL, Ledesma Matín MC, de Unamuno Pérez P. Eccemas. Semergen 2005; 31(2):67-85.

INFECCIONES HERPÉTICAS

María Herrero Moyano, Javier Alcántara González, Leticia Calzado Villarreal, Alex R. Sosa Carrasco, Paula Molina Ávila, Julio Tito Camino Acha.

1. VIRUS HERPES SIMPLE (VHS1 Y VHS2)

Introducción

La infección por virus de herpes simple (VHS) tiene una alta prevalencia; hasta un 80% de la población tiene anticuerpos específicos. **Existen dos subtipos**, el VHS 1, que produce la mayoría de infecciones extragenitales y un 20% de las genitales, y el VHS 2 que produce la mayoría de infecciones genitales y algunas extragenitales.

Clínica.

El cuadro de primoinfección aparece a los 3-7 días tras la exposición. Puede ir acompañado de sintomatología general como fiebre, adenopatías y malestar junto con las lesiones cutáneas típicas: vesículas dolorosas agrupadas sobre base eritematosa que después dan lugar a erosiones y costras. En niños, la primoinfección orofacial puede dar lugar a un cuadro de gingivoestomatitis llamativa. Sin embargo, la mayoría de primoinfecciones orofaciales son asintomáticas, al contrario que las genitales, que suelen dar lugar a cuadros de vulvovaginitis o balanopostitis dolorosas. Tras la primoinfección, el virus queda en fase de latencia en los ganglios de las raíces dorsales y puede reactivarse en situaciones de estrés, fiebre, inmunodepresión, cirugías o traumatismos locales, exposición UV, etc.

Otras formas clínicas: menos frecuentes como el panadizo herpético, herpes gladiatorum, eccema herpeticum (erupción variceliforme de Kaposi), úlceras profundas de curso crónico en inmunodeprimidos. También formas extracutáneas: herpes ocular, encefalitis herpética, proctitis y el herpes neonatal.

Diagnóstico

En muchas ocasiones el diagnóstico clínico es suficiente. Para una confirmación diagnóstica la prueba más sensible es una PCR. Si se requiere un diagnóstico rápido se puede realizar un **citodiagnóstico de Tzanck**, aunque esta prueba es menos sensible.

Tratamiento

En pacientes inmunocompetentes:

• **Primoinfección:**

- **Aciclovir 200 mg:** 200 mg cinco veces al día durante 7 a 10 días vía oral. Si se producen complicaciones neurológicas, 5 mg/kg por vía intravenosa cada 8 horas durante 5 días.
- **Valaciclovir 500 mg:** 1 g cada 12 horas durante 7-10 días vía oral.
- **Famciclovir 250 mg:** 250 mg cada 8 horas durante 7-10 días vía oral.

• **Recidivas:** las formas leves pueden manejarse únicamente con fomentos antisépticos (como sulfato de zinc) dos veces al día. Las formas más severas requieren tratamiento oral:

- **Aciclovir 200 mg:** 200 mg cinco veces al día durante 5 días vía oral, 400 mg tres veces al día durante 5 días vía oral u 800 mg tres veces al día durante 2 días vía oral.
- **Valaciclovir 500 mg:** 500 mg cada 12 horas durante 3 días vía oral o 1 g cada 24 horas durante 5 días vía oral.
- **Famciclovir 125 mg:** 125mg cada 12 horas durante 5 días vía oral o 1 g dos veces al día durante 1 día vía oral.

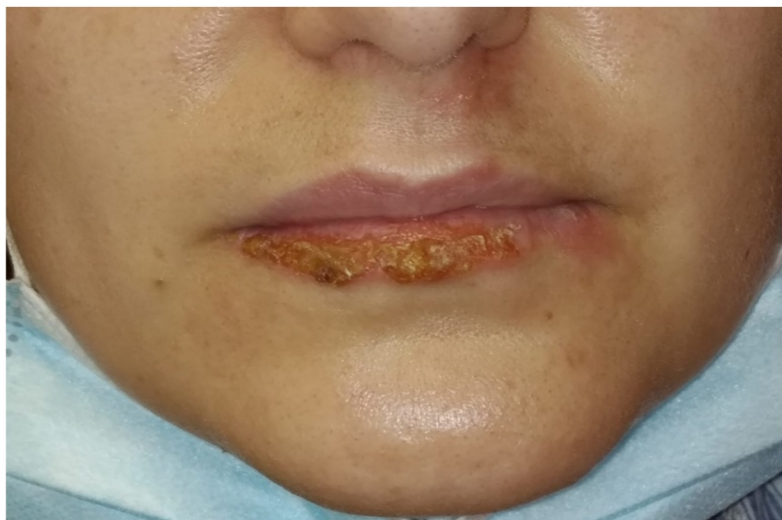
En pacientes inmunodeprimidos:

• **Primoinfección:**

- **Aciclovir 200 mg:** 400 mg cinco veces al día vía oral o 5- 10 mg/kg cada 8 horas vía intravenosa hasta la curación de las heridas.

• **Recidivas:**

- **Aciclovir 200 mg:** 400 mg cada 8 horas durante 5-10 días vía oral.



Herpes simple labial extenso en fase de costra

2. VIRUS VARICELA ZÓSTER (HHV-3)

Este virus tiene dos manifestaciones clínicas: **la primoinfección**, que produce la varicela, y **la reactivación**, que origina el herpes zóster.

2.1. VARICELA

Introducción

Se trata de una infección de distribución mundial que afecta a niños menores de 10 años en el 90% de las ocasiones. Se contagia por vía respiratoria teniendo la máxima infectividad hasta una semana después del exantema.

El cuadro clínico transcurre en tres fases bien definidas:

- **Pródromos:** fiebre, malestar general, anorexia, cefalea y artralgias.
- **Exantema:** comienza en polo cefálico con expansión hacia el tronco. Discurre en “oleadas” de máculas que se transforman en pápulas, vesículas umbilicadas y costras, por lo que se pueden encontrar múltiples lesiones en diferentes estadios. Pruriginoso.
- **Complicaciones:** raras en niños. La más frecuente es la sobreinfección bacteriana. En adultos la complicación típica es la neumonía. Otras: encefalitis, síndrome de Reye, ataxia cerebelosa aguda, hepatitis, glomerulonefritis, neuritis óptica.

Diagnóstico

Mediante PCR del líquido de una vesícula.

Tratamiento

• **Inmunocompetentes:**

- **Niños:** sólo se realiza tratamiento sintomático: antihistamínicos, antipiréticos (evitar AAS por posible síndrome de Reye) y soluciones antisépticas.
- **Adultos:** Aciclovir 800mg 5 veces al día, durante 7 días.

• **Inmunodeprimidos:**

- **Aciclovir:** 10 mg/kg i.v. ajustar según la función renal, cada 8 horas durante 10 días.



Lesiones cutáneas típicas de varicela: vesículas que tienden a umbilicarse, sobre base eritematosa.

2.2. HERPES ZÓSTER

Introducción

La reactivación a nivel local del virus de la varicela ocurre en dos fases:

- **Pródromos:** dolor y parestesias en el dermatomo afectado.
- **Erupción herpética** (pápulas o placa eritematosa sobre las que aparecen las vesículas agrupadas) afectando un dermatomo, unilateral, sin atravesar línea media.
- **Complicaciones:**
 - **Neuralgia postherpética:** aparece en un 10-20% de los casos, aumentando la incidencia con la edad.
 - **Diseminación:** puede ocurrir en un 10% de los pacientes inmunodeprimidos.
 - **Mucho más raro:** meningoencefalitis, neumonitis... (inmunodeprimidos).
 - **La infección** por varicela en las primeras 20 semanas de gestación se asocia con un riesgo del 2% del síndrome de varicela congénita en el feto.

Cuadros clínicos particulares:

- **Herpes zóster oftálmico (V1):** en un 30-40% hay afectación de la rama nasociliar, con lesiones herpéticas en punta nasal (signo de Hutchinson) y afectación del globo ocular.
- **Síndrome de Ramsay-Hunt (VII par craneal):** parálisis facial, otalgia y lesiones herpéticas en concha auricular o conducto auditivo externo.
- **Herpes zóster sacro (S2-S3):** puede acompañarse de cistitis o retención aguda de orina.

Diagnóstico

PCR del líquido de una vesícula.

Tratamiento:

- **Sintomático:** en fase vesiculosa/erosiva se aplican fomentos de sulfato de zinc 1/1000 en solución acuosa cada 12 horas, mientras que en fase de costra se pueden aplicar pomadas antibióticas o vaselina pura.
- **Antiviral:** sobre todo cuando se inicia en las primeras 72 horas, reduce la severidad y la duración de las lesiones cutáneas y de la neuralgia postherpética.
 - **Aciclovir:** 800 mg cinco veces al día durante 7 días.
 - **Famciclovir:** 500 mg cada 8 horas durante 7 días.
 - **Valaciclovir:** 1 g cada 8 h durante 7 días.
 - **Brivudina** 125mg: 1 comprimido cada 24h durante 7 días. ATENCIÓN: La interacción entre brivudina y fluoropirimidinas (por ejemplo: capecitabina, 5-FU, tegafur, flucitasina, etc) es potencialmente mortal.
 - **Pacientes inmunodeprimidos e infección diseminada:** aciclovir 10 mg/kg de peso IV cada 8 horas durante 7-10 días en infusión lenta (1 hora) (ajustar para insuficiencia renal)

- **Tratamiento de la neuralgia postherpética:** Opiáceos, gabapentina y pregabalina, antidepresivos tricíclicos, crema de capsaicina, bloqueo nervioso.



Herpes zóster extenso (C3-C7) mostrando lesiones típicas (vesículas y costras sobre base eritematoedematosa de distribución metamérica)

3. PITIRIASIS ROSADA DE GIBERT

Introducción

Erupción eritematodescamativa aguda y autolimitada que aparece sobre todo en pacientes jóvenes. Su etiología es incierta, aunque se ha asociado al herpes virus tipo 6 y 7.

Clínicamente cursa en dos fases:

- **Aparición de la «placa heráldica»** (una placa rosa-anaranjada ovalada de 2 a 5 cm, con collarete descamativo, generalmente en el tronco) que antecede en 1-2 semanas a la aparición del exantema. En ocasiones se acompaña de cuadro pseudogripal.
- **Múltiples pápulas y placas ovales** de la misma coloración, distribuidas en el tronco y las raíces de los miembros de forma característica, «en árbol de navidad». El tiempo medio de resolución del cuadro es de 6 a 8 semanas.

Diagnóstico

- El diagnóstico es clínico.
- Diagnóstico diferencial: sífilis secundaria, psoriasis en gotas.

Tratamiento

No precisa al tratarse de un cuadro autolimitado y generalmente asintomático. Si presenta prurito puede tratarse con **antihistamínicos orales** (cetirizina 10mg 1 cada 24h V.O.) y **lociones calmantes** (mentol, calamina) y/o **corticoides tópicos**.

BIBLIOGRAFÍA

- Downing C, Mendoza N, Sra K, Tying SK. Human herpesviruses, in Bologna JL, Schaffer JV, Cerroni L (eds): Dermatology, 4th ed. New York: Elsevier; 2018: 1400-1421.
- Wood GS, Reizner GT. Other papulosquamous disorders. In: Bologna JL, et al. Dermatology. , 4th ed. New York: Elsevier; 2018:170-2.

- Fitzpatrick J, High W. Urgent Care Dermatology: Symptom-Based Diagnosis 1st Edition. Elsevier 2017.
- Rodríguez-Jiménez P, Estébanez Corrales A, Molina Ruiz AM, et al. Manual de dermatología para residentes, 2ª ed. Barcelona: Editorial glosa; 2019.

PATOLOGÍA UNGUEAL

Rubén Linares Navarro, Paula Fernández Canga, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN.

El aparato ungueal protege la piel distal de los dedos y facilita las funciones prensiles. Está compuesto por la placa ungueal (cuya parte proximal se denomina lúnula), el lecho ungueal, la matriz ungueal, el pliegue ungueal proximal y el hiponiquio (Fig.1).

Los queratinocitos que constituyen la matriz ungueal se forman a partir del epitelio germinativo de la matriz ungueal. El crecimiento completo de las uñas de las manos ocurre entre 6 y 8 meses, mientras que el de las uñas de los pies, entre 12 y 18 meses. El aparato ungueal puede alterarse por dermatosis infecciosas, inflamatorias, traumáticas, tóxicas, tumorales o genéticas.

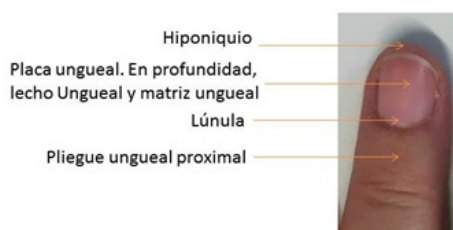


Figura 1: Anatomía del aparato ungueal

BIBLIOGRAFÍA

- Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General. 8ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2014.
- Haneke E. Nail surgery. J Cutan Aesthet Surg. 2011;4(3):163.
- Daniel III CR, Jellinek NJ, Rubin AI, Scher RK. Scher and Daniel's Nails Diagnosis, Surgery, Therapy [Internet]. 2018 [citado octubre de 2019]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-65649-6>

HEMATOMA SUBUNGUEAL

Rubén Linares Navarro, Paula Fernández Canga, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN.

El hematoma subungueal es la acumulación de sangre bajo la placa ungueal como consecuencia del sangrado del lecho, debido a un traumatismo en dicha región (Fig. 8 y Fig. 9). Es conveniente descartar complicaciones como fracturas (especialmente de la falange distal), heridas extensas del lecho ungueal o infección.



Figura 8: Hematoma subungueal con afectación de más del 50% de la superficie ungueal



Figura 9: Hematoma subungueal con afectación de menos del 50% de la superficie ungueal

DIAGNÓSTICO.

El diagnóstico se basa en la anamnesis (antecedente traumático) y la exploración física. La dermatoscopia puede ser de ayuda en casos seleccionados.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con lesiones pigmentadas de la matriz ungueal como el melanoma y el nevus subungueal. En el hematoma, la colección hemática se irá desplazando con el crecimiento de la uña que nacerá normocoloreada en su región proximal.

TRATAMIENTO.

- La trepanación está indicada en hematomas agudos (menos de 48 horas de evolución), extensos, dolorosos y sin afectación del lecho ungueal. Se recomienda emplear métodos que no supongan una gran compresión de la placa ungueal contra el lecho ungueal, como la electrocauterización o la aspiración con aguja de insulina.
- La extirpación de la uña no se recomienda salvo que exista riesgo de pérdida del dedo o de la uña por herida extensa del lecho ungueal.

BIBLIOGRAFÍA

- Palamarchuk HJ, Kerzner M. An improved approach to evacuation of subungual hematoma. J Am Podiatr Med Assoc. 1989;79(11):566-8.
- Roser SE, Gellman H. Comparison of nail bed repair versus nail trephination for subungual hematomas in children. J Hand Surg Am. 1999;24(6):1166-70.
- Bonisteel PS. Practice tips. Trephining subungual hematomas. Can Fam Physician. 2008;54(5):693.
- Pingel C, McDowell C. Subungual Hematoma Drainage. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 [citado octubre de 2019]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482508/>
- Seaberg DC, Angelos WJ, Paris PM. Treatment of subungual hematomas with nail trephination: a prospective study. Am J Emerg Med. 1991;9(3):209-10.
- Batrick N, Hashemi K, Freij R. Treatment of uncomplicated subungual haematoma. Emergency Medicine Journal. 2003;20(1):65.

LESIONES PIGMENTADAS

Rubén Linares Navarro, Paula Fernández Canga, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La proliferación de melanocitos en la matriz o lecho ungueal provoca una hiperpigmentación del aparato ungueal denominada melanoniquia. Diferenciar si dicha lesión es benigna (Fig. 6) (nevus, lentigo) o maligna (Fig.7) (melanoma lentiginoso acral) puede suponer un reto.

DIAGNÓSTICO

Los signos de alarma que han de hacernos sospechar un melanoma y biopsiar la lesión en pacientes que presenten melanoniquia longitudinal son los siguientes:

- Aparición en la edad adulta.
- Afectación de un solo dedo, especialmente pulgar, índice o primer dedo del pie.
- Melanoniquia longitudinal de más de 3mm de ancho, especialmente si hay ensanchamiento proximal.
- Coloración heterogénea.
- Oscurecimiento o crecimiento de una melanoniquia ya presente.
- Fisuras o distrofia ungueal asociada.
- Pigmentación que se extiende al pliegue ungueal, conocido como signo de Hutchinson.

TRATAMIENTO

En caso de que estos signos no estén presentes, se recomienda monitorización clínica y/o dermatoscópica.



Figura 6: Nevus juncional acral subungueal.



Figura 7: Melanoma lentiginoso acral subungueal.

BIBLIOGRAFÍA

- Tosti A, Piraccini BM, de Farias DC. Dealing with Melanonychia. Semin Cutan Guía del médico de urgencias Dermatología Med Surg.2009;28(1):49-54.
- Ruben BS. Pigmented Lesions of the Nail Unit: Clinical and Histopathologic Features. Semin Cutan Med Surg.2010;29(3):148-58.
- Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrist BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General. 8ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2014.

ONICOMICOSIS

Rubén Linares Navarro, Paula Fernández Canga, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La onicomicosis es la infección fúngica de las uñas. Los agentes causales más frecuentes son los dermatofitos (en torno al 68% del total de las onicomicosis, en especial *Trichophyton rubrum*), seguido de las levaduras (29%, destacando *Candida Albicans*) y de los mohos no dermatofitos (3%).

Los factores de riesgo de onicomicosis incluyen: diabetes mellitus, inmunosupresión, edad avanzada, tiña pedis (por diseminación), psoriasis, hiperhidrosis, obesidad y humedad local, ya sea por motivos ocupacionales, deporte o calzado oclusivo.

Las onicomicosis se clasifican según la zona anatómica afectada:

- Subungueal distal y externa (Fig.4 y Fig. 5): la más común. Consiste en una decoloración amarillenta, blanquecina o marronácea de la parte distal de la uña que va extendiéndose hacia toda la placa ungueal. Presenta hiperqueratosis subungueal y onicolisis.
- Blanca superficial: punteado o parche blanquecino en la placa ungueal.
- Subungueal proximal: se relaciona con inmunodepresión grave. Comienza como una mancha blanquecina a nivel del pliegue ungueal proximal que puede llegar a la lúnula y la parte proximal de la placa ungueal.



Figura 4: Onicomicosis subungueal distal y externa.



Figura 5: onicomicosis subungueal distal y externa.

DIAGNÓSTICO.

El diagnóstico clínico ha de confirmarse mediante examen en fresco con KOH (hidróxido potásico) o cultivo. Ha de plantearse el diagnóstico diferencial con la psoriasis y la dystrofia ungueal.

TRATAMIENTO:

Es conveniente confirmar el diagnóstico previamente al tratamiento.

Entre los fungicidas tópicos se emplea:

- **Amorolfina ISDIN 50mg/ml barniz de uñas**: aplicar en uñas de pies o manos 1 o 2 veces a la semana durante 6 meses, limar y limpiar con alcohol antes de aplicar la laca. Usar guantes para realizar procedimiento.
- **Ciclopiroxolamina en laca ungueal** (2 aplicaciones a la semana durante al menos 6 meses para las uñas de las manos y hasta 1 año para las de los pies).

El antifúngico sistémico más empleado es:

- **Terbinafina 250mg vía oral**: 250mg/día durante 6 semanas en manos y 12 semanas en pies.
- Otras opciones terapéuticas son los **azoles** sistémicos en pauta intermitente.

En casos leves, el tratamiento tópico puede ser suficiente, aunque por ser prolongado, tiene mala adherencia. En casos moderados-graves el tratamiento de elección será sistémico e incluso combinado.

BIBLIOGRAFÍA

- Vañó S, Jaén Olasolo P. Dermatología. Madrid: Medical & Marketing Communications; 2016.
- Saunte DML, Piraccini BM, Sergeev AY, Prohić A, Sigurgeirsson B, Rodríguez-Cerdeira C et al. A survey among dermatologists: diagnostics of superficial fungal infections – what is used and what is needed to initiate therapy and assess efficacy? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019;33(2):421-427.
- Ameen M, Lear JT, Madan V, Mohd Mustapa MF, Richardson M. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of onychomycosis 2014. Br J Dermatol. 2014;171(5):937-58.
- Sigurgeirsson B, Baran R. The prevalence of onychomycosis in the global population - A literature study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014;28(11):1480-91.
- Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General. 8ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2014.

PSORIASIS UNGUEAL

Rubén Linares Navarro, Paula Fernández Canga, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Entre un 80 y un 90% de las personas afectadas de psoriasis pueden presentar afectación ungueal a lo largo de su vida. Se caracteriza por:

- Hiperqueratosis subungueal.
- Mancha oleosa o de aceite o parches asalmonados (Fig.2): decoloración amarillenta o rosada del lecho ungueal.
- Onicólisis: separación de la placa ungueal del lecho.
- Hemorragias en astilla: finas líneas rojizas o marrónáceas subungueales.
- Pitting o punteado ungueal (Fig.3): pequeños hoyuelos en la lámina ungueal



Figura 2: Mancha de aceite.



Figura 3: Pitting o punteado ungueal.

DIAGNÓSTICO.

El diagnóstico es clínico y se establece mediante una anamnesis y una exploración física completa en busca de lesiones compatibles con psoriasis. La onicomycosis es el principal diagnóstico diferencial. Ambas patologías comparten la hiperqueratosis subungueal y onicólisis distal, siendo el pitting y la mancha oleosa más frecuentes en la psoriasis. Ante la duda, se debe tomar un cultivo de la uña.

No hay que olvidar la posibilidad de una artritis psoriásica concomitante, que ocurre hasta en el 40% de los pacientes. Se trata de una artritis seronegativa, oligoarticular asimétrica, siendo típicas la inflamación de la articulación interfalángica distal y la dactilitis.

TRATAMIENTO

- Medidas generales: aplicación regular de emolientes, mantener las uñas cortas, evitar traumatismos, humedad e irritantes.
- **En casos leves** y sin afectación funcional el tratamiento preferido es el tópico, siendo de primera línea los **corticoides (clobetasol al 8% laca ungueal)** y los **análogos de la vitamina D** (Daivonex 50 microgramos/gr crema: aplicar dos veces al día en las uñas afectadas, no usar en embarazadas), en monoterapia o en combinación. No existe esquema estándar para el tratamiento.
- **En moderada o grave**, con síntomas significativos, afectación funcional, afectación cutánea de más del 8% o síntomas articulares, el paciente deberá ser derivado al especialista para valorar el inicio de tratamiento sistémico (acitretino, inmunosupresores, inhibidores del TNF-alfa, etc.).

BIBLIOGRAFÍA.

- Tan ES, Chong WS, Tey HL. Nail Psoriasis: a review. Am J Clin Dermatol. 2012;13(6):375-88.

- Crowley JJ, Weinberg JM, Wu JJ, Robertson AD, Van Voorhees AS; National Psoriasis Foundation. Treatment of Nail Psoriasis: best practice recommendations from the Medical Board of the National Psoriasis Foundation. JAMA Dermatol. 2015;151(1):87-94.
- Oram Y, Akkaya AD. Treatment of Nail Psoriasis: Common Concepts and New Trends. Dermatol ResPract.2013;2013:180496.
- Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General. 8ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2014.
- Vañó S, Jaén Olasolo P. Dermatología. Madrid: Medical & Marketing Communications; 2016.